

காநீகா ஸௌக்ய ரௌதீ அபிபாசன புரூக

பெண்கள் நலம் – நோயாளர் கல்விப் புத்தகம்

ஸரீரி, ப்ரஹ்மிசென் பஹ் ஸஹ நாரிவீடி ஸாயன காநீகாவின் ஸஹா ஓடுநீவீலே ஸௌக
கர்ப்பிணிகள், பிரசவத்திற்குப் பின் மற்றும் மகப்பேறு அல்லாத மகளிர் நோய் கிளிநிக்
பெண்களுக்கான கற்பித்தல் புத்தகம்



ஃயலுபிஸாவ (ஃநி
ரௌதீ)

நீரிழிவு (சர்க்கரை
நோய்)

அபி ருபீர பீவநய
(ப்ரஃபர்)

உயர் இரத்த அழுத்தம்
(பிரஷர்)

கஃரோஃபி ரௌதீ

தைராய்டு நோய்கள்

அடூம்

ஆஸ்துமா

கரஹர்கஹ ஸஹ நிஃ
ஹ

உடல் பருமனும்
ஆரோக்கிய எடையும்

කාන්තා සෞඛ්‍ය රෝගී අධ්‍යාපන පොත

පெண்கள் நலம் – நோயாளர் கல்விப் புத்தகம்

ගෞරව, ප්‍රසූතියෙන් පසු සහ නාරිවේද සායන කාන්තාවන් සඳහා ඉගැන්වීමේ පොත
கர்ப்பிணிகள், பிரசவத்திற்குப் பின் மற்றும் மகப்பேறு அல்லாத மகளிர் நோய் கிளினிக்
பெண்களுக்கான கற்பித்தல் புத்தகம்

Prepared by

Dr. Archuthan Nithiyananthan (RHO)

සකස් කළේ | தயாரித்தவர்

Translated and Proofread by

Dr. Yasodara Amarasinghe (RHO)

Dr. Kasunika Perera (RHO)

Dr. Madara Malsirini (RHO)

පරිවර්තනය සහ සෝදිසි කළේ | மொழிபெயர்ப்பும் மெய்ப்புத் திருத்தமும்

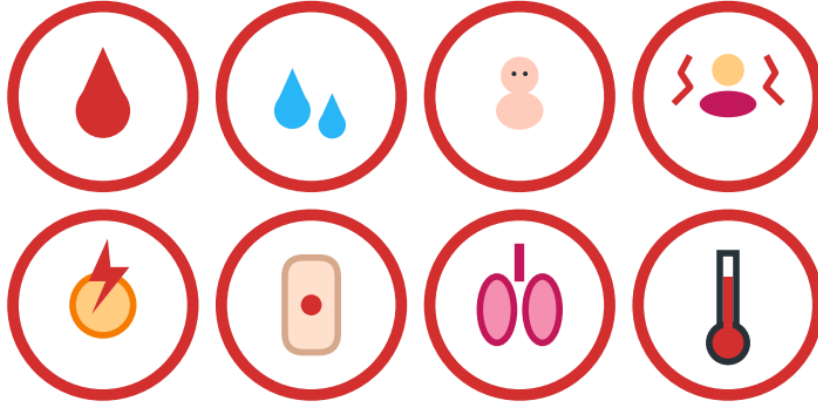
Unofficial teaching book - for use inside the clinic only

-
- An illustration of a health educator, a woman in an orange sari, sitting at a wooden table with a woman in a blue floral dress. They are both smiling and looking at an open book on the table that shows various fruits and vegetables. The educator is pointing to a page in the book. In the background, there is a white wall with a fan, a potted plant, and a poster with health-related icons like a heart, a cross, and a water drop.

- අධික රුධිර වහනය (පැයක් ඇතුළත පැඩි එකක් තෙමෙන තරම්), නැතහොත් ගහර්නි කාලයේ ඕනෑම රුධිර වහනයක්.
- වතුර ගැලීම, නැතහොත් දරුවාගේ වලනය බොහෝ අඩුවීම.
- වලිස්සුව හෝ සිහිසුන් වීම.
- දරුණු හිසරදය, ඇස් ඳිඳිපිට විදලි එලි පෙනීම හෝ බොඳවී පෙනීම.

- டர்ஜன் லெபி லேதாவ.
- ஸ்டீம் டீலீலே டீலீலே, டீலீலே டீலீலே டீலீலே டீலீலே டீலீலே.
- டீலீலே டீலீலே, டீலீலே டீலீலே டீலீலே டீலீலே டீலீலே.
- டீலீலே டீலீலே டீலீலே: டீலீலே டீலீலே டீலீலே டீலீலே டீலீலே டீலீலே, டீலீலே, டீலீலே டீலீலே டீலீலே டீலீலே டீலீலே, டீலீலே டீலீலே டீலீலே.

- அதிக இரத்தப்போக்கு (ஒரு மணி நேரத்தில் பேட் நனையுமளவு), அல்லது கர்ப்ப காலத்தில் எந்த இரத்தப்போக்கும்.
- பனிக்குடம் உடைதல் அல்லது குழந்தையின் அசைவு மிகவும் குறைதல்.
- வலிப்பு, அல்லது மயங்கி விழுதல்.
- கடுமையான தலைவலி, கண்முன் ஒளிக்கீற்றுகள் அல்லது பார்வை மங்குதல்.
- கடுமையான வயிற்று வலி.
- மூச்சு விடச் சிரமம், அல்லது உதடுகள் நீல நிறமாதல்.
- அதிகக் காய்ச்சல், அல்லது துர்நாற்றமுள்ள வெள்ளைப்படுதல்.
- அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பின்: காயம் திறத்தல் அல்லது சீழ் வடிதல், காய்ச்சல், கால் தசை வலி அல்லது வீக்கம், திடீர் மூச்சுத் திணறல்.



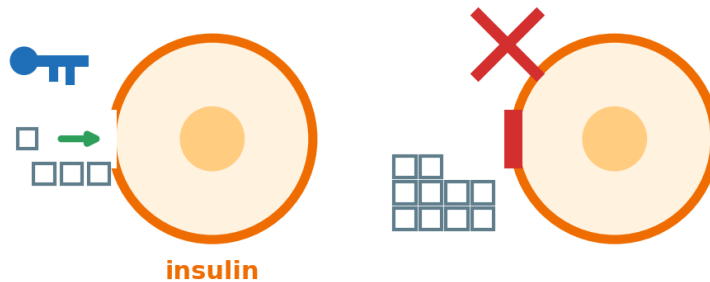
පරිච්ඡේදය 1: දියවැඩියාව (සීනි රෝගය)

அத்தியாயம் 1: நீரிழிவு (சர்க்கரை நோய்)

D-01 | All

දියවැඩියාව යනු කුමක්ද?
நீரிழிவு என்னுள் என்ன?

- ශරීරයේ ශක්තිය සඳහා රුධිරයේ ඇති සීනි ශරීර සෛල තුළට යැවීමට ඉන්සියුලින් උපකාරී වේ.
 - දියවැඩියාවේදී ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණවත් නොවේ, නැතහොත් නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකරයි. එමනිසා රුධිරයේ සීනි ඉහළ මට්ටමක පවතී.
 - ගහර්නී කාන්තාවන්ගේ:
 - ගහර්ණීභාවයට පෙර සිට ඇති දියවැඩියාව (වගර් 1 හෝ වගර් 2).
 - ගහර්නී දියවැඩියාව (GDM) - ගහර්ණීභාවයේදී ආරම්භ වී සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසූතියෙන් පසු සුව වේ.
 - ගහර්නී නොවන කාන්තාවන්ගේදී: බොහෝවිට වගර් 2 දියවැඩියාව.
 - දකුණු ආසියානු කාන්තාවන් අතර දියවැඩියාව සුලභ බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ගහර්නී කාන්තාවන් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.
- இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை சக்திக்காக உடற்கலங்களுக்குள் அனுப்ப இன்சலின் உதவுகிறது.
 - நீரிழிவில் இன்சலின் போதுமானதாக இல்லை, அல்லது சரியாக வேலை செய்யாது. இரத்தத்தில் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கும்.
 - கர்ப்பிணிகளில்:
 - கர்ப்பத்திற்கு முன்பிருந்தே உள்ள நீரிழிவு (வகை 1 அல்லது வகை 2).
 - கர்ப்பகால நீரிழிவு (GDM) - கர்ப்பத்தின்போது தொடங்கி, பொதுவாகப் பிரசவத்திற்குப் பின் சரியாகிவிடும்.
 - கர்ப்பமில்லாத பெண்களில்: பெரும்பாலும் வகை 2 நீரிழிவு.
 - தென்னாசியப் பெண்களுக்கு நீரிழிவு அதிகமாக வருவதால், இலங்கையில் எல்லாக் கர்ப்பிணிகளுக்கும் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது.



සීනි පාලනය කළ යුත්තේ ඇයි?

சர்க்கரையை ஏன் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்?

සීනි ඉහළ ගියොත්	සිදුවිය හැකි දේ
ගහර්නී	දරුවා විශාල වීම, ප්‍රසූතිය අපහසු වීම, උපතින් පසු දරුවාගේ සීනි අඩු වීම, අධි රුධිර පීඩනය, ආසාදන, සිසේරියන් වැඩි වීම
ගහර්නී නොවන	ශල්‍යකෝරයෙන් පසු සුවය ප්‍රමාද වීම, කුලාල සහ ගහර්නී ආසාදන, ඩීසීට් (කැසීම සහිත සුදු ස්‍රාවය), මුත්‍රා ආසාදන, ඇස්, චකුගඩු, ස්නායු සහ හදවත් රෝග

- හොඳින් පාලනය කළ විට සෞඛ්‍ය සම්පන්න දරුවන් ලැබේ. ආරක්ෂිත ලෙස ශල්‍යකෝර කරගැනීමට හැකි වේ.

சர்க்கரை அதிகமாக இருந்தால்	ஏற்படக்கூடியவை
கர்ப்பிணி	குழந்தை பெரிதாகத், கடினமான பிரசவம், பிறந்த பின் குழந்தையின் சர்க்கரை குறைதல், உயர் இரத்த அழுத்தம், தொற்றுகள், அதிக சிசேரியன்
கர்ப்பமில்லாதவர்	அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பின் காயம் ஆறத் தாமதம், காயம் மற்றும் கருப்பைத் தொற்றுகள், பூஞ்சைத் தொற்று (அரிப்புடன் வெள்ளைப்படுதல்), சிறுநீர்த் தொற்றுகள், கண், சிறுநீரகம், நரம்பு மற்றும் இதய நோய்கள்

- நன்கு கட்டுப்படுத்தினால் ஆரோக்கியமான குழந்தைகளும் பாதுகாப்பான அறுவைச் சிகிச்சைகளும் கிடைக்கும்.



බබ්බේ සීනි ඉලක්ක

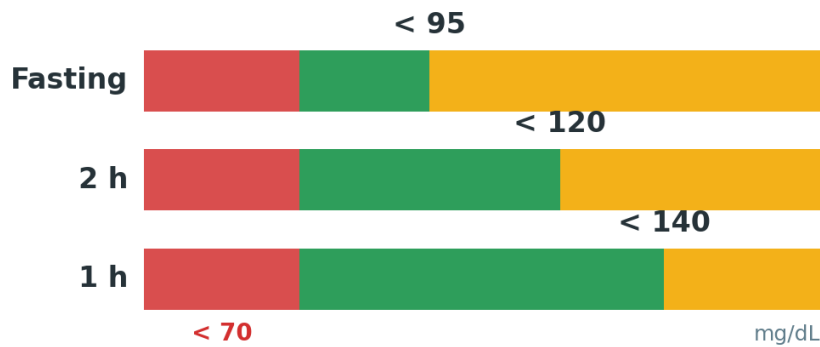
உங்கள் சர்க்கரை இலக்குகள்

වේලාව	ගහර්නී (mg/dL)	ගහර්නී නොවන
නිරාහාරව (උදේ ආහාරයට පෙර)	95 ට අඩු	මෙහි ලියන්න: ____ [CHECK]
ආහාරය ආරම්භ කර පැය 1 කට පසු	140 ට අඩු	
ආහාරය ආරම්භ කර පැය 2 කට පසු	120 ට අඩු	මෙහි ලියන්න: ____

- 70 ට අඩු වීම ඉතා පහළ මට්ටමකි. D-16 බලන්න.

நேரம்	கர்ப்பிணி (mg/dL)	கர்ப்பமில்லாதவர்
வெறும் வயிற்றில் (காலை உணவுக்கு முன்)	95 க்குக் குறைவு	
உணவு தொடங்கி 1 மணி நேரத்திற்குப் பின்	140 க்குக் குறைவு	
உணவு தொடங்கி 2 மணி நேரத்திற்குப் பின்	120 க்குக் குறைவு	

- 70 க்குக் குறைவது மிகவும் குறைந்த அளவு. D-16 ஐப் பார்க்கவும்.



නිවසේදී සීනි පරීක්ෂා කිරීම

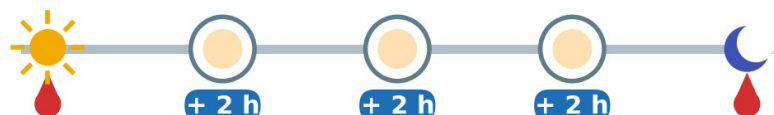
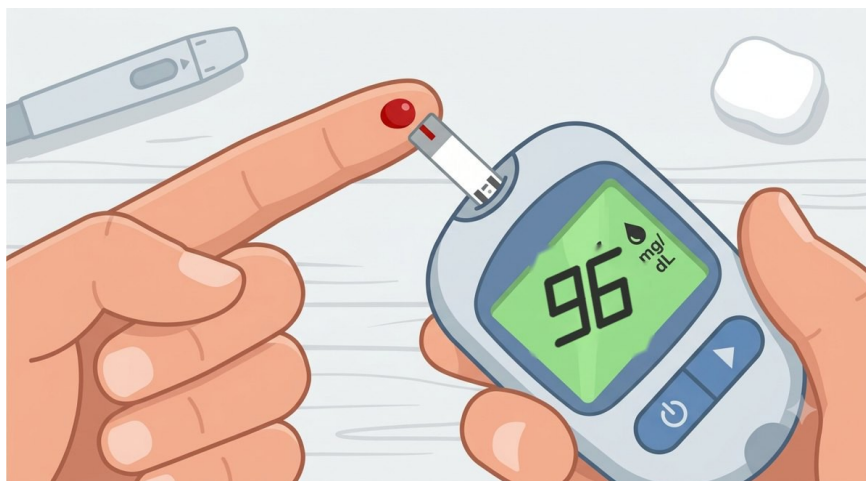
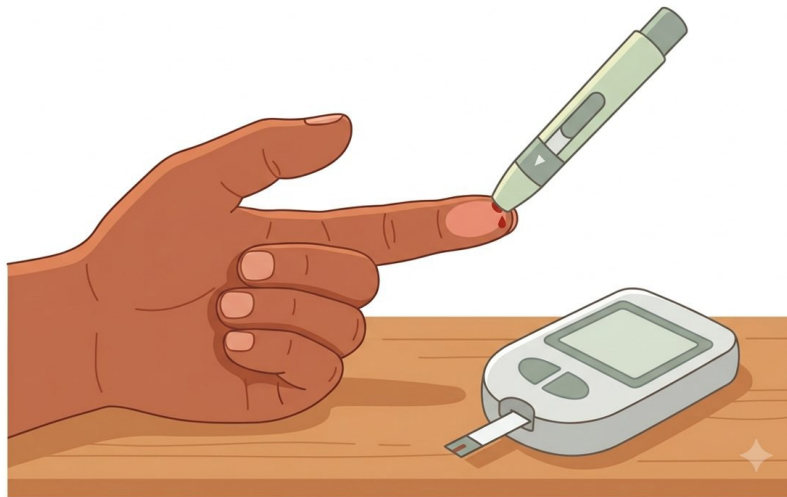
வீட்டில் சர்க்கரை பரிசோதனை

1. සබන් සහ උණු වතුරෙන් අත් සෝදි හොඳින් වියළන්න.

2. මීටරයට අලුත් ස්ට්ரீප් එකක් දමන්න.
3. අලුත් ලැන්සෙට් එකකින් ඇඟිල්ලේ පැත්තට අතින්න. සෑම වතාවකම වෙනත් ඇඟිල්ලක් භාවිතා කරන්න.
4. ලේ බිංදුවක් ස්ට්ரීප් එකට ස්පර්ශ කරන්න.
5. ප්‍රතිඵලය සහ වේලාව ලියා තබන්න.
6. ලැන්සෙට් එක තියුණු දේ දමන බෝතලයට දමන්න.
 - ගෙර්නී: නිරාහාරව, සහ උදේ, දහවල් සහ රාත්‍රී ආහාරවල ආහාර ගැනීම ආරම්භ කල වෙලේ සිට පැය 2 කට පසු. ඉන්සියුලින් ගන්නේ නම් නිදාගැනීමට පෙරද.
 - ගෙර්නී නොවන: සායනයෙන් උපදෙස් දෙන පරිදි.
 - සෑම පැමිණීමකටම ඔබේ සටහන් පොත හෝ සායන පොත ගෙන එන්න.

1. சோப்பு மற்றும் வெதுவெதுப்பான நீரால் கைகளைக் கழுவி நன்கு உலர்த்தவும்.
2. மீட்டரில் புதிய ஸ்டிரிப் செருகவும்.
3. புதிய லான்செட்டால் விரல் நுனியின் பக்கத்தில் குத்தவும். ஒவ்வொரு முறையும் வேறு விரலைப் பயன்படுத்தவும்.
4. இரத்தத் துளியை ஸ்டிரிப்பில் தொடவும்.
5. முடிவையும் நேரத்தையும் எழுதி வைக்கவும்.
6. லான்செட்டை கூரான பொருட்களுக்கான போத்தலில் போடவும்.
 - எப்போது (கர்ப்பிணி): வெறும் வயிற்றில், மேலும் காலை, மதியம், இரவு உணவின் முதல் கவளத்திலிருந்து 2 மணி நேரத்திற்குப் பின். இன்சலின் எடுப்பவர்கள் படுக்கைக்கு முன்பும் செய்யவும் .
 - எப்போது (கர்ப்பமில்லாதவர்): கிளினிக்கில் கூறியபடி.
 - ஒவ்வொரு வருகைக்கும் உங்கள் குறிப்பேட்டையோ கிளினிக் புத்தகத்தையோ கொண்டுவருங்கள்.





D-05 | All

දියවැඩියාව සමඟ නිවැරදි ආහාර රටාව நீரிழிவுடன் ஆரோக்கியமான உணவு

- පිහානෙන් හාගයක්: එළවළු සහ කොළ වගර් (මැල්ලම්, බෝංචි, කැරට්, වට්ටක්කා, වම්බලු).
- හතරෙන් එකක්: බත්, ඉඳි ආපේප හෝ වෙනත් පිෂ්ඨය. කෝපේපයකින් මැනගන්න.
- හතරෙන් එකක්: ප්‍රෝටීන් (මාළු, බිත්තර, කුකුළු මස්, පරිප්පු, කඩල, මුං ඇට).
- තෙල් හෝ පොල් ස්වල්පයක්. දිනකට වතුර විදුරු 8 ක්.
- කුඩා ආහාර වේල් සහ අතුරුපස, සෑම දිනකම එකම වේලාවලට. ආහාර වේල් මහ නොහරින්න. බඩගින්නේ නොසිටින්න.
- ගහර්නි: රාත්‍රි ආහාරයන් උදේ ආහාරයන් අතර පැය 10-12 ට වැඩි නොවිය යුතුය.

- தட்டில் பாதி: காய்கறிகள் மற்றும் கீரை வகைகள் (மல்லும், பீன்ஸ், கேரட், பூசணி, கத்தரிக்காய்).
- கால் பங்கு: சோறு, இடியாப்பம் அல்லது வேறு மாவுச்சத்து உணவு. கோப்பையால் அளந்து எடுக்கவும்.
- கால் பங்கு: புரதம் (மீன், முட்டை, கோழி, பருப்பு, கொண்டைக்கடலை, பாசிப்பயறு).
- சிறிதளவு எண்ணெய் அல்லது தேங்காய். நாளொன்றுக்கு 8 குவளை தண்ணீர்.
- சிறிய உணவுகளும் சிற்றுண்டிகளும், தினமும் ஒரே நேரங்களில். உணவை விட்டுவிடாதீர்கள். பட்டினி கிடக்காதீர்கள்.
- கர்ப்பிணி: இரவு உணவுக்கும் காலை உணவுக்கும் இடையே 10-12 மணி நேரத்திற்கு மேல் இடைவெளி கூடாது.



D-06 | All

நோர்ராகை ஸ்ரூ ஸ்ரூ ஸ்ரூ கல ஸ்ரூ ஸ்ரூ

தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியவை, குறைக்க வேண்டியவை

நோர்ராகை	ஸ்ரூ கரனை ஸ்ரூ ஸ்ரூ
ஸ்ரூ ஸ்ரூ - ஸ்ரூ ஸ்ரூ; ஸ்ரூ ஸ்ரூ ஸ்ரூ, ஸ்ரூ, ஸ்ரூ	ஸ்ரூ ஸ்ரூ, ஸ்ரூ, ஸ்ரூ ஸ்ரூ ஸ்ரூ ஸ்ரூ
ஸ்ரூ ஸ்ரூ ஸ்ரூ ஸ்ரூ	ஸ்ரூ, ஸ்ரூ, ஸ்ரூ ஸ்ரூ, ஸ்ரூ
ஸ்ரூ, ஸ்ரூ, ஸ்ரூ ஸ்ரூ, ஸ்ரூ	ஸ்ரூ ஸ்ரூ, ஸ்ரூ, ஸ்ரூ, ஸ்ரூ, ஸ்ரூ
ஸ்ரூ ஸ்ரூ ஸ்ரூ ஸ்ரூ (ஸ்ரூ, ஸ்ரூ)	ஸ்ரூ ஸ்ரூ ஸ்ரூ, ஸ்ரூ ஸ்ரூ ஸ்ரூ, ஸ்ரூ ஸ்ரூ

- "දියවැඩියා රෝගීන් සඳහා" යැයි කියන රසකැවිලිවලද සීනි ඉහළ නංවයි. ස්වල්ප වශයෙන් පමණක් අනුභව කරන්න.
- ආගමික වතාවත් හේතුවෙන් උපවාස කරන්නේ නම්: පළමුව සායනය සමඟ කතා කර උපදෙස් ලබා ගන්න

தேர்ந்தெடுங்கள்	குறையுங்கள் அல்லது தவிர்க்கவும்
சிவப்பரிசிச் சோறு - சிறிய அளவில்; அவித்த பாசிப்பயறு, காராமணி, கொண்டைக்கடலை	வெள்ளைச் சோறு, பாண், நூடில்ஸ் பெரிய அளவில்
கீரை வகைகள், காய்கறிகள்	சீனி, வெல்லம், பனங்கருப்பட்டி, தேன்
மீன், முட்டை, கோழி, பருப்பு	இனிப்புகள், கேக், பிஸ்கட், கவுன், கொகிஸ்
சிறிய முழுப் பழங்கள் (கொய்யா, பப்பாளி)	பழச்சாறு, போத்தல் குளிர்பானம், சீனி போட்ட தேநீர்
சீனி இல்லாத திரிபோஷா	பொரித்த உணவுகள்

- "நீரிழிவுக்கானது" என்று சொல்லப்படும் இனிப்புகளும் சர்க்கரையை உயர்த்தும். சிறிதளவு மட்டுமே எடுக்கவும்
- மத நோன்பு இருந்தால், முதலில் கிளிநிக்கில் கலந்துபேசங்கள்.



D-07 | All

ක්‍රියාශීලීව සිටින්න

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

- සෑම ආහාර වේලකින් පසුවම මිනිස්තු 10 ක් ඇවිදින්න, හෝ දිනකට මිනිස්තු 30 ක් ඇවිදින්න.
- ගහර්නී කාලයේදී, රුධිර වහනය, කරකැවිල්ල, පපුවේ වේදනාව, ගැබ් හැකිලීම හෝ දරුවාගේ වලනය අඩුවීම තිබේ නම් නවතා සායනයට දන්වන්න.
- ඉන්සියුලින් ගත්තේ නම්, හිස් බඩින් වසායාම නොකරන්න.

- ஒவ்வொரு உணவுக்குப் பின்னும் **10 நிமிடம்** நடக்கவும், அல்லது நாளொன்றுக்கு **30 நிமிடம்** நடக்கவும்.
- கர்ப்ப காலத்தில், இரத்தப்போக்கு, தலைச்சுற்றல், நெஞ்சு வலி, கருப்பை சுருக்கங்கள் அல்லது குழந்தையின் அசைவு குறைதல் இருந்தால் நிறுத்திவிட்டுக் கிளினிக்கிற்குத் தெரிவியுங்கள்.
- இன்சலின் எடுத்தால், வெறும் வயிற்றில் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டாம்.

D-08 | All

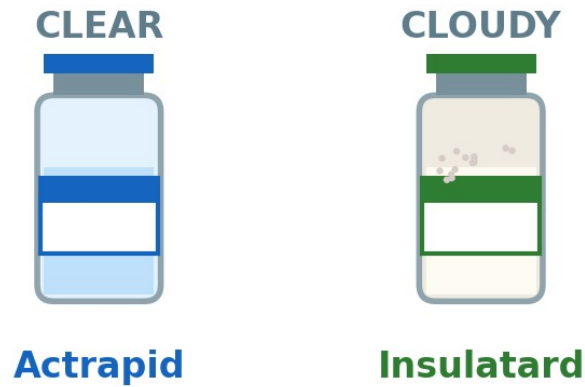
- **ஊர்நீ தோவன:** ஓடுலு (஁ஃ; மெல்மேல்) ஂத ஂதற வில் ஔ்ம்யூடின், ஁படிஸ் ட்ட பர்தி ஈதார் ஂதற ஑ன். இல காலகி பரிதி நவ்வன்னல னை வெதத் கருன்னல பது.
 - **ஊர்நீ:** ஢ௌஸா காந்தாவன் ஈதார் பாளுடியை, ஐவுஷ நழ் ஔ்ம்யூடின்லின் பாளுய வே. ஂதறழுன் மெல்மேல் ஑னி.
 - ஔ்ம்யூடின் ட்டுவால் ஈர்க்கினடி. பிய ஈடுலு விதக் தாவே.
 - ஂதற ட்யலுவிசா ஓடுலு ஊர்ணாவையீ ஈர்க்கின தாவே (஁ஃ; எட்மிக்கிடயிட). ஑லி ஑ுகில ஂளமு கருன்னை நழ ஂாயயல மே லவ கியன்.
 - ஑ுலகல்லரியல பேர, இல ட்யலுவிசாவ ஈறி லவ, இல ஑ுலகல்லரியல பேர பரித்தா கருத யிட்ட வேறுவருன் கியன். இவை ஂதற போக ஑ை பன்.
- கற்ப்பமில்லாதவர்: மாத்திரைகள் (எ.கா. மெட்டம்போர்மின்) மற்றும் சிலருக்கு இன்சலின். அறிவுறுத்தியபடி உணவுடன் எடுக்கவும். நீங்களாகவே நிறுத்தவோ மாற்றவோ வேண்டாம்.
 - கர்ப்பிணி: பெரும்பாலான பெண்களுக்கு உணவுக் கட்டுப்பாடு, தேவைப்பட்டால் இன்சலின். சிலர் மெட்டம்போர்மின் எடுப்பார்கள்.
 - இன்சலின் குழந்தைக்குப் பாதுகாப்பானது. அது போதை பழக்கமாகிவிடாது.
 - சில நீரிழிவு மாத்திரைகள் கர்ப்பத்தில் பாதுகாப்பற்றவை (எ.கா. கிளிள்ளசைட்). கர்ப்பமாகத் திட்டமிட்டால் கிளினிக்கிற்குத் தெரிவியுங்கள்.
 - அறுவைச் சிகிச்சைக்கு முன், உங்களைக் கவனிப்பவர்கள் எல்லோரிடமும் உங்களுக்கு நீரிழிவு இருப்பதைத் தெரிவித்து, உங்கள் குறிப்பேட்டைக் கொண்டுவாருங்கள்.



3. **பாபிகா கரந ஒநீ஑ீ஑ீநீ லௌ டேக (ஒநீ஑ீ஑ீநீ பாபிகா கரநீநநீ ஑டீபா)**
 இங்கு பயன்படுத்தும் இரண்டு இன்஑லின் வகைகள் (இன்஑லின்
 ஂடுப்பவர்களுக்கு)

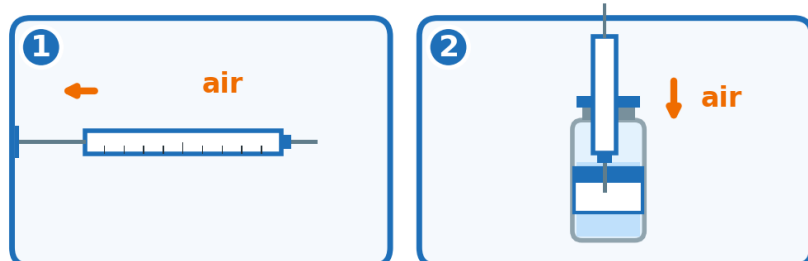
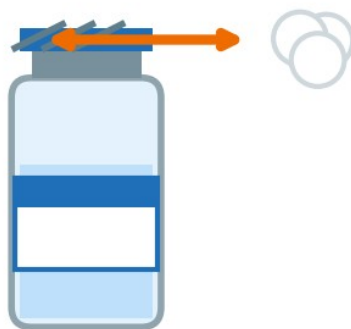
- දෙකම කිසිවිටෙක පටලවා නොගන්න. සෑම වතාවකම ලේඛනය කියවන්න.

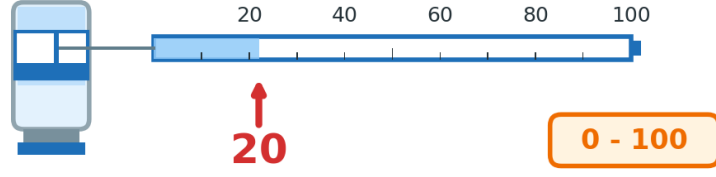
- இரண்டையும் ஒருபோதும் மாற்றிக் குழப்பிக்கொள்ளாதீர்கள். ஒவ்வொரு முறையும் லேபிளப் படியுங்கள்.



D-10 | insulin users

- **දිය වන ඉන්සියුලින් මිනිත්තු 30 කින් පමණ ක්‍රියා කරයි.** ආහාර ප්‍රමාද වුවහොත් සීනි ඉතා පහළ යයි.
 - **1. ආහාරය පිසගෙන පිළියෙල කරන්න. 2. ඉන්පසු එන්නත ගන්න. 3. මිනිත්තු 30 ක් ඇතුළත ආහාර ගන්න.**
 - **ආහාර ගත නොහැකි නම්, දිය වන ඉන්සියුලින් නොගන්න. සායනයෙන් උපදෙස් ලබාගන්න.**
- **කරையும் (Soluble) இன்சலின் சுமார் 30 நிமிடத்தில் வேலை செய்யும். உணவு தாமதமானால் சர்க்கரை மிகவும் குறையும்.**
 - **1. உணவைச் சமைத்து மேசையில் வைப்பார்கள். 2. பிறகு ஊசி போடுங்கள். 3. 30 நிமிடத்திற்குள் சாப்பிடுங்கள்.**
 - **சாப்பிட முடியாவிட்டால், கரையும்(soluble) இன்சலினைப் போடாதீர்கள். கிளினிக்கில் கேளுங்கள்.**





D-12 | only if taught at the clinic

புறநீர் சහ லெடி ஓன்ஃபுலின் லகல ஃரீன்ஸ்யே ஃபு கிரீல (ஃபுஸனஸ்யேஃ ஃபுலன்லா ஃபுலன்லா ஃபுலன்லா)

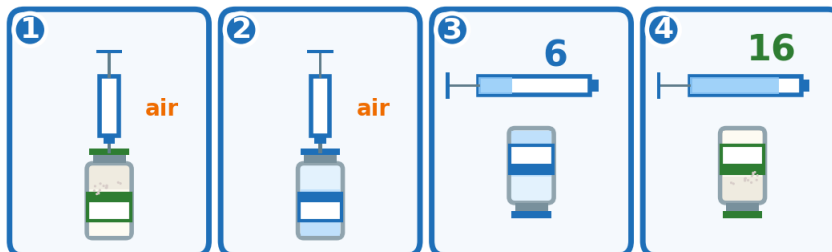
தெளிவான, கலங்கலான இன்ஸுலின் ஓரே சிரிஞ்சில் கலத்தல் (கிளிளிக்கில் கற்றுக்கொடுத்திருந்தால் மட்டும்)

லகல கலாஓன்: புறநீர் ஓன்ஃபுலின் லகல லெடி லகல ஃபுலன்லா.

1. லெடி லகல லகல லகல ஃபுலன்லா. ஓன்ஃபுலின் ஓன் ஃபுலன்லா. ஓன்ஃபுலின் ஃபுலன்லா லகல.
2. புறநீர் லகல லகல லகல ஃபுலன்லா. புறநீர் லகல ஃபுலன்லா.
3. ஓன்ஃபுலின் லெடி லகல ஃபுலன்லா. லகல ஃபுலன்லா ஃபுலன்லா.
 - ஃபுலன்லா: புறநீர் 6 + லெடி 10 = 16 ஃபுலன்லா ஃபுலன்லா.
 - லெடி லகல லகல ஃபுலன்லா, ஃபுலன்லா ஃபுலன்லா ஃபுலன்லா ஃபுலன்லா.

நினைவில் லகலங்கள்: தெளிவானது ஢ுதலில், கலங்கலானது ஢ின்னர்.

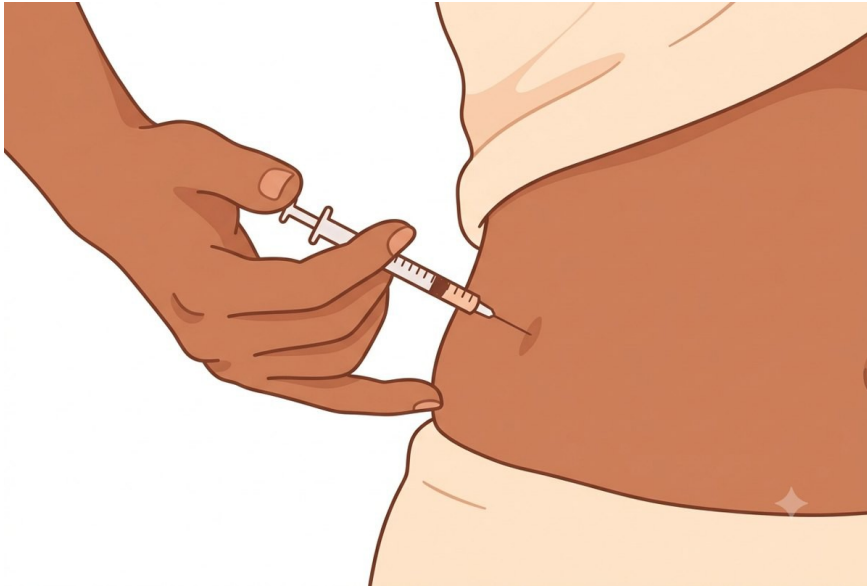
1. கலங்கலான குப்பிக்குள் காற்றைச் செலுத்துங்கள். ஊசியை லெளியே ஂடுங்கள். இன்ஸுலின் இழுக்க லெண்டாம்.
2. தெளிவான குப்பிக்குள் காற்றைச் செலுத்துங்கள். தெளிவான ஂளவை இழுத்து ஂடுங்கள்.
3. ஊசியைக் கலங்கலான குப்பிக்குள் செலுத்துங்கள். ஢ொத்த ஂண் லரை இழுக்கலும்.
 - ஂடுத்துக்காட்டு: தெளிவானது 6 + கலங்கலானது 10 = 16 லரை இழுக்கலும்.
 - கலங்கலானது ஂதிக஢ாக லந்துலிட்டால், ஂல்லாலற்றையும் கலாட்டிலிட்டு ஢ீண்டும் தலாடங்குங்கள்.

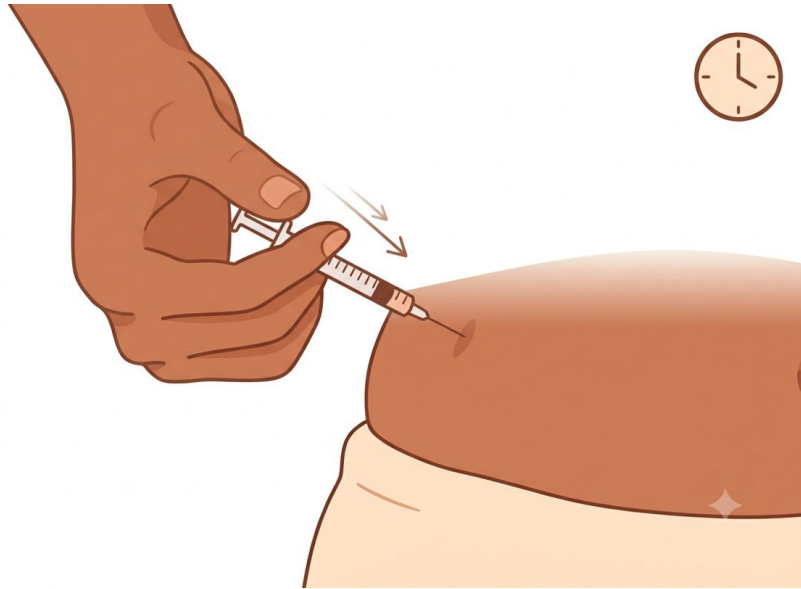


එන්නත ලබා ගැනීම (ඉන්සියුලින් ගන්නා කාන්තාවන් සඳහා) ஊசி போடுதல் (இன்சலின் எடுப்பவர்கள்)

1. පිරිසිදු, වියළි ස්ථානයක් තෝරන්න (D-14).
2. ඉඳිකවුට කෙළින්ම ඇතුළු කරන්න. ඔබ කෙටිවූ කෙනෙක් නම් සම ඇඟරගන්න.
3. පීස්ටනය සෙමින් සම්පූර්ණයෙන් තල්ලු කරන්න.
4. ඉවතට ගැනීමට පෙර 10 දක්වා ගිණන් කරන්න.
5. අතුල්ලන්න එපා.
6. පියන නැවත දමන්න එපා. පිරිත්පය තියුණු දේ දමන බෝතලයට (පියනක් සහිත ශක්තිමත් ප්ලාස්ටික් බෝතලයක්) දමන්න.
7. සෑම වතාවකම අලුත් පිරිත්පයක් භාවිතා කරන්න.

1. சுத்தமான, உலர்ந்த இடத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள் (D-14).
2. ஊசியை நேராகச் செலுத்துங்கள். மெலிந்தவர்கள் தோலைச் சிறிது பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்.
3. உலக்கையை மெதுவாக முழுவதும் அழுத்துங்கள்.
4. வெளியே எடுப்பதற்கு முன் 10 வரை எண்ணுங்கள்.
5. தேய்க்க வேண்டாம்.
6. மூடியை மீண்டும் போட வேண்டாம். சிரிஞ்சை கூரான பொருட்களுக்கான போத்தலில் (மூடியுடன் கூடிய உறுதியான பிளாஸ்டிக் போத்தல்) போடுங்கள்.
7. ஒவ்வொரு முறையும் புதிய சிரிஞ்ச்.





D-14 | insulin users

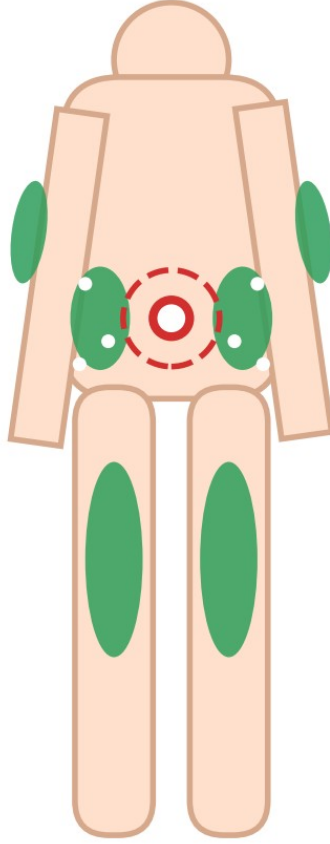
එන්නත ලබා ගත යුතු ස්ථාන (ඉන්සියුලින් ලබාගන්නේ සඳහා)
 ඤාපී ථොරුම ඔඩඟ්කූ (ඔඟ්සලිඟ් ආරුථථචර්කූ)

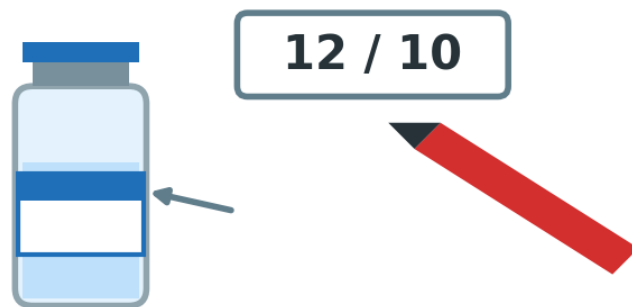
ස්ථානය	භාවිතය
උදරය (නාභියේ සිට සෙන්ටිමීටර 5 ක් ඇතිව; ගහර්ණිභාවයේ අග කාලයේ පැති පැතික)	ආහාරවලට පෙර දිය වන ඉන්සියුලින්
කලවය (ඉදිරිපස, පිටත)	නිදහැනීමට පෙර අයිසොෆේන්
ඉහළ අතේ පිටුපස, තට්ටම	ඕනෑම එකක්

- සෑම වතාවකම ස්ථානය වෙනස් කරන්න. පෙර ස්ථානයෙන් සෙන්ටිමීටර 2 ක් පමණ ඉවතින් තබන්න.
- ගැටිති, කැළැල් හෝ කැලුණු තැන්වලට එන්නත් නොකරන්න. ගැටිති ගැන සායනයට කියන්න.

இடம்	பயன்பாடு
வயிறு (தொப்புளிலிருந்து 5 செ.மீ. விலகி; கர்ப்பத்தின் பிற்பகுதியில் பக்கவாட்டில்)	உணவுக்கு முன் கரையும் (Soluble) இன்சலின்
தொடை (முன்புறம், வெளிப்புறம்)	படுக்கைக்கு முன் ஐசோஃபேன்
மேல் கையின் பின்புறம், புட்டம்	எதுவும்

- ஒவ்வொரு முறையும் இடத்தை மாற்றுங்கள். முந்தைய இடத்திலிருந்து சுமார் 2 செ.மீ. தள்ளி வையுங்கள்.
- கட்டிகள், தழும்புகள், காயம்பட்ட இடங்களில் போட வேண்டாம். கட்டிகள் இருந்தால் கிளினிக்கிற்குத் தெரிவியுங்கள்.



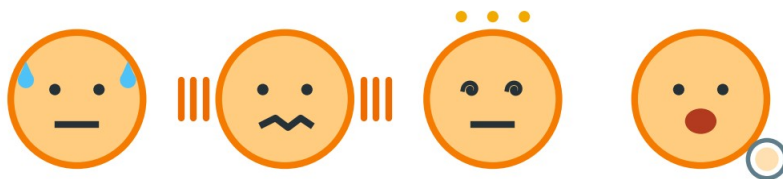


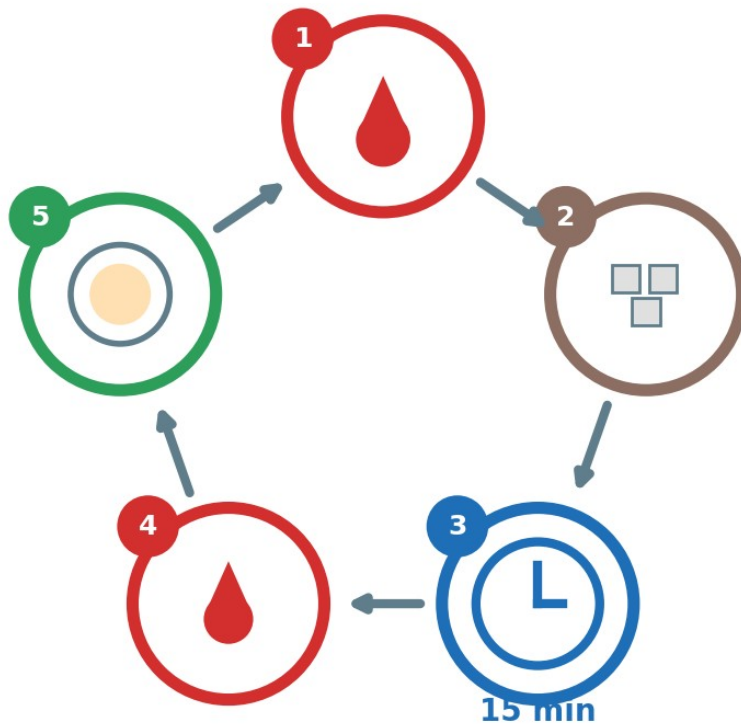
සිනි අඩු වීම: 70 ට අඩු (ඉන්සියුලින් සහ වැඩිලඬු ගන්නන්)

சர்க்கரை குறைதல்: 70 க்குக் கீழ் (இன்சலின், மாத்திரை எடுப்பவர்கள்)

- සලකුණු: වෙවිලිම, දහඩිය දූමිම, හදවත වෙගයෙන් ගැහීම, බඩගින්න, කරකැවිල්ල, ඔප් කැක්කුම, සිතේ පටලැවිලි සහගත බව.
- හේතුව: ප්‍රමාද වූ හෝ මහ හැරුණු ආහාර වේල, ඉන්සියුලින් වැඩිවීම, ව්‍යායාම, වමනය.
- කළ යුත්තේ:
 - පරීක්ෂා කරන්න. අඩු නම්, හෝ අඩු යැයි හැඟී පරීක්ෂා කළ නොහැකි නම්, වහාම ප්‍රතිකාර කරන්න.
 - චතුර විදුරුවක අඩකට තේ හැඳි 3 ක් සීනි දමා ගන්න, හෝ පැණි බීමක්.
 - මිනිත්තු 15 ක් රැඳී සිටින්න. නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තවම අඩු නම් නැවත කරන්න.
 - ඉන්පසු කෙටි ආහාරයක් හෝ ප්‍රධාන ආහාරය ගන්න.
- සැමවිටම සීනි රැගෙන යන්න. ඔබේ පවුලේ අයට කියන්න.
- ඇයට ගිල ගත නොහැකි නම් හෝ සිහිපුත් නම්: කටට කිසිවක් නොදමන්න. ඇයව පැත්තකට හරවා තබන්න. වහාම රෝහලට යන්න.
- සමහර රුධිර පීඩන සහ තයිරොයිඩ් වැඩිලට් (ලැබටලෝල්, ප්‍රොප්‍රානොලෝල්) මෙම සලකුණු සහවයි. ඔබේ පරීක්ෂාව මත රඳ පවතින්න.

- அறிகுறிகள்: நடுக்கம், வியர்வை, இதயம் வேகமாகத் துடித்தல், பசி, தலைச்சுற்றல், தலைவலி, குழப்பம்.
- காரணங்கள்: தாமதமான அல்லது தவறவிட்ட உணவு, அதிக இன்சலின், உடற்பயிற்சி, வாந்தி.
- செய்ய வேண்டியது:
 1. பரிசோதியுங்கள். குறைவாக இருந்தால், அல்லது குறைவாக உணர்ந்து பரிசோதிக்க முடியாவிட்டால், உடனே சிகிச்சை செய்யுங்கள்.
 2. அரை குவளை தண்ணீரில் 3 தேக்கரண்டி சீனி கலந்து குடியுங்கள், அல்லது இனிப்புப் பானம்.
 3. 15 நிமிடம் காத்திருங்கள். மீண்டும் பரிசோதியுங்கள். இன்னும் குறைவாக இருந்தால் மீண்டும் செய்யுங்கள்.
 4. பிறகு சிற்றுண்டி அல்லது உணவு சாப்பிடுங்கள்.
- எப்போதும் சீனியைக் கையில் வைத்திருங்கள். குடும்பத்தினருக்குச் சொல்லுங்கள்.
- அவரால் விழுங்க முடியாவிட்டால் அல்லது மயக்கமாக இருந்தால்: வாயில் எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம். ஒரு பக்கமாகச் சாய்த்துப் படுக்க வையுங்கள். உடனே மருத்துவமனைக்குச் செல்லுங்கள்.
- சில இரத்த அழுத்த, தைராய்டு மாத்திரைகள் (லபெடலால், புரோப்ரானோலால்) இந்த அறிகுறிகளை மறைக்கக்கூடும். பரிசோதனையை நம்புங்கள்.

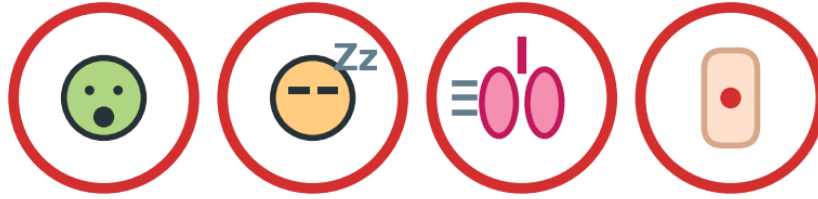




இனம் அஃதீசு வு விம் (கீழ்ப்படிதா)
உடல்நலமில்லாதபோது (எல்லோரும்)

- Women's Health – Patient Education Book | Page 23

- மருத்துவமனைக்கு வாருங்கள்: வாந்தியால் திரவங்களை உள்ளே தங்க வைக்க முடியாவிட்டால், அதிகத் தாகம், தூக்கக் கலக்கம், வேகமான சுவாசம் அல்லது வயிற்று வலி இருந்தால்.
- சர்க்கரை இலக்கை விட இரு முறை அதிகமாக இருந்தால்: அதே நாளில் கிளினிக்கிற்குத் தெரிவியுங்கள்.



D-18 | P

**গের্ভা কালচেই দেইবুচীয়া: দেইবা সগ প্রজ্ঞানী (গের্ভা)
கர்ப்பகால நீரிழிவு: குழந்தையும் பிரசவமும் (கர்ப்பிணி)**

- දරුවාගේ වලනය: සති 28 පමණ සිට දරුවාගේ සාමාන්‍ය වලන රටාව හඳුනාගන්න. වලනය අඩු වුවහොත් එවෙලෙහිම පැමිණෙන්න.
- ප්‍රසූතිය ඔබේ සායනය සමඟ සැලසුම් කෙරේ. ඔබේ සටහන් පොත, බෙහෙත් සහ සායන පොත ගෙන එන්න.
- ප්‍රසූතියෙන් පසු: GDM වැඩිලට් හෝ ඉන්සියුලින් නවතී. කලින් සිට ඇති දියවැඩියාව: ඉන්සියුලින් අවශ්‍යතාව අඩු වේ. නව මාත්‍රාවක් ලබා දෙනු ලැබේ.
- මුල් කාලයේම කිරි දෙන්න. කිරි දීමේදී ඉන්සියුලින් සහ මෙට්ෆෝමින් ආරක්ෂිතයි.

- குழந்தையின் அசைவுகள்: சுமார் 28 வாரங்களிலிருந்து குழந்தையின் வழக்கமான அசைவு முறையைக் கவனியுங்கள். அசைவு குறைந்தால் அதே நாளில் வாருங்கள்.
- பிரசவம் உங்கள் கிளினிக்குடன் திட்டமிடப்படும். உங்கள் குறிப்பேடு, மருந்துகள், கிளினிக் புத்தகத்தைக் கொண்டுவருங்கள்.
- பிரசவத்திற்குப் பின்: **GDM** மாத்திரைகள் அல்லது இன்சலின் நிறுத்தப்படும். முன்பே இருந்த நீரிழிவு: இன்சலின் தேவை குறையும். புதிய அளவு தரப்படும்.
- சீக்கிரமே தாய்ப்பால் கொடுங்கள். தாய்ப்பாலூட்டும்போது இன்சலினும் மெட்ஃபோர்மினும் பாதுகாப்பானவை.

நாரீவேடி காத்நாவத்ளே டீயவ்விடயவ (ஊர்நீ நாவன)

மகளிர் நோய் கிளினிக் பெண்களில் நீரிழிவு (கர்ப்பமில்லாதவர்)

- லெக்மர்ஸெ பைர்: டிவெ ஸெபத் பாவ ஊன ப்ந். ப்ந டிவெ லெபைன் வெநப் கர்நு லூயி ஸக. ஸபடேப் நாவ்லுணஊன் ஓந்ஃபுடின் நாவவ்ந்ந்.
- லெக்மர்ஸெத் பஃ: ஊடி ஃநி ஸாலய யநு வெஊவ் ஃபய ஸஊ ஈபு ஈபாடி.
- ஃபீவ் ஈபாடிய (கஃஃ, ஃபு ஃபவ) ஸஊ ஡ுநா ஈபாடி ஃநி ஓஊ வ் வ்விடயெத் வெ. ஃபயநயவ கியத்.
- PMOS ஸஊ ஈபுவ்வ் டிபப் டீயவ்விடயவ வ்லுடிவெ ஈபடிநவ வ்வி கர்டி. வஃர்கவ வர்க் ஃநி ப்நீக்ஊ கர்ந்.
- ஊடி ஊநீவ் ஸ்லஃபு கர்நவாடி? கலின் ப்லீணைந், லெபைன் ஸஊ ஃநி ஈர்க்ஊ ம்வ்வகவ ஊன ப்வ்வ.

- அறுவைச் சிகிச்சைக்கு முன்: உங்கள் குறிப்பேட்டைக் கொண்டுவருங்கள். அன்று உங்கள் மருந்துகள் மாற்றப்படலாம். சொல்லப்படாவிட்டால் இன்சலினை நிறுத்த வேண்டாம்.
- அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பின்: நல்ல சர்க்கரைக் கட்டுப்பாடு என்றால் வேகமாக ஆறுதல், குறைவான தொற்று.
- பூஞ்சைத் தொற்று (அரிப்பு, வெள்ளைப்படுதல்) மற்றும் சிறுநீர்த் தொற்றுகள் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கும்போது அதிகம் வரும். கிளினிக்கிற்குத் தெரிவியுங்கள்.
- PMOS மற்றும் ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் நீரிழிவு வரும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கும். ஆண்டுக்கு ஒருமுறை சர்க்கரை பரிசோதியுங்கள்.
- கர்ப்பமாகத் திட்டமிடுகிறீர்களா? முதலில் வாருங்கள், மருந்துகளையும் சர்க்கரையையும் பாதுகாப்பான நிலைக்குக் கொண்டுவர.

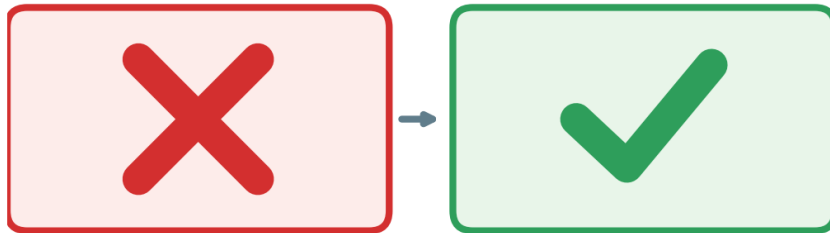


මිථ්‍යා සහ සත්‍ය (සියලුදෙනා)

கட்டுக்கதைகளும் உண்மைகளும் (எல்லோரும்)

මිථ්‍යාව	සත්‍යය
"ඉන්සියුලින් මගේ දරුවාට හානි කරයි."	ඉහළ සීනි දරුවාට හානිකරයි. ඉන්සියුලින් ආරක්ෂිතයි.
"ඉන්සියුලින් පටන් ගත්තොත් කවදවත් නවත්වන්න බෑ."	GDM වලට හානිකරන ප්ලාස්මා ඉන්සියුලින් ප්ලාස්මායින් පසු නවතී.
"මම දෙදෙනෙකුට කැමට ඕනෑම."	විකක් වැඩියෙන් පමණි, දෙදෙනෙකුට නොවේ.
"සීනි නැති රසකැවිලි නිදහස්."	ස්වල්ප වශයෙන් පමණි.
"දියවැඩියාව කියන්නේ බත් නැහැ."	මනින ලද ප්‍රමාණයෙන් බත් කැමට කමක් නැත.

கட்டுக்கதை	உண்மை
"இன்சலின் என் குழந்தைக்குத் தீங்கு செய்யும்."	அதிகச் சர்க்கரையே குழந்தைக்குத் தீங்கு. இன்சலின் பாதுகாப்பானது.
"இன்சலின் ஆரம்பித்தால் ஒருபோதும் நிறுத்த முடியாது."	GDM இன்சலின் பிரசவத்திற்குப் பின் நிறுத்தப்படும்.
"நான் இருவருக்குச் சாப்பிட வேண்டும்."	சற்றுக் கூடுதல் மட்டும்; இரு மடங்கு அல்ல.
"சீனி இல்லாத இனிப்புகள் தடையில்லை."	சிறிதளவு மட்டுமே.
"நீரிழிவு என்றால் சோறு கூடாது."	அளந்த அளவில் சோறு சாப்பிடலாம்.



පරිච්ඡේදය 2: අධි රුධිර පීඩනය (ප්‍රෙෂර්) අத்தියායම 2: உயர் இரத்த அழுத்தம் (பிரஷர்)

H-01 | All

රුධිර පීඩනය යනු කුමක්ද?

இரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன?

- රුධිර පීඩනය (BP) යනු ඔබේ රුධිර නාලවලට රුධිරය යොදන බලයයි.
- එය සංඛ්‍යා දෙකකින් ලියයි, උදා: **120/80**.
- **140/90** හෝ ඊට වැඩි නම් අධිකයි.
- අධි රුධිර පීඩනය බොහෝවිට කිසිදු රෝග ලක්ෂණයක් නොපෙන්වයි. එබැවින් එය පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

- இரத்த அழுத்தம் (BP) என்பது இரத்தக் குழாய்களின் மீது இரத்தம் செலுத்தும் விசை.
- இது இரண்டு எண்களாக எழுதப்படும், எ.கா. **120/80**.
- **140/90** அல்லது அதற்கு மேல் என்றால் அதிகம்.
- உயர் இரத்த அழுத்தம் பெரும்பாலும் எந்த அறிகுறியும் காட்டாது. அதனால்தான் அது பரிசோதிக்கப்படுகிறது.



H-02 | All

අධි රුධිර පීඩන වගර් (සියලුදෙනා)

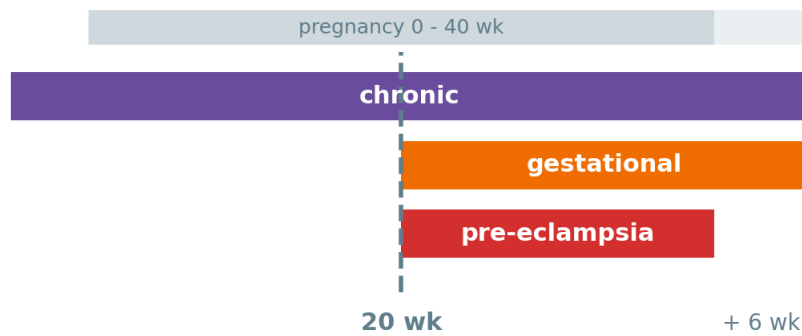
உயர் இரத்த அழுத்த வகைகள் (எல்லோரும்)

වගර්ය	එය කුමක්ද
දිගුකාලීන අධි රුධිර පීඩනය	ගහර්ණිභාවයට පෙර, හෝ ගහර්නී නොවන කාන්තාවක තුළ
ගහර්ණිභාවයේ අධි රුධිර පීඩනය	සති 20 න් පසු අලුතින් ඇතිවේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ රසුනියෙන් පසු සුව වේ.
ප්‍රී-එක්ලැම්ප්සියා	සති 20 න් පසු අධි රුධිර පීඩනය සමඟ මුත්‍රාවල ප්‍රෝටීන් හෝ වෙනත් අවයව බලපෑම්. හයානක විය හැක.

- පාලනය නොකළ අධි රුධිර පීඩනය ආසාදනය, හෘද සහ වකුගඩු රෝග ඇති කළ හැක.
- ගහර්ණිභාවයේදී එය දරුවාගේ වධර්නය අඩාල වීම, කල් නොපිරී උපත සහ වලිප්පු ඇති කළ හැක.

වகை	அது என்ன
நீண்டகால உயர் இரத்த அழுத்தம்	கர்ப்பத்திற்கு முன்பே, அல்லது கர்ப்பமில்லாத பெண்ணில்
கர்ப்பகால உயர் இரத்த அழுத்தம்	20 வாரங்களுக்குப் பின் புதிதாக வருவது. பொதுவாகப் பிரசவத்திற்குப் பின் சரியாகிவிடும்.
ப்ரீ-எக்லாம்ப்சியா	20 வாரங்களுக்குப் பின் உயர் இரத்த அழுத்தத்துடன் சிறுநீரில் புரதம் அல்லது பிற உறுப்புப் பாதிப்பு. ஆபத்தானது.

- கட்டுப்படுத்தப்படாத உயர் இரத்த அழுத்தம் பக்கவாதம், இதய, சிறுநீரக நோய்களை ஏற்படுத்தலாம்.
- கர்ப்பத்தில் இது குழந்தையின் வளர்ச்சிக் குறைவு, குறைப்பிரசவம், வலிப்பு ஆகியவற்றையும் ஏற்படுத்தலாம்.



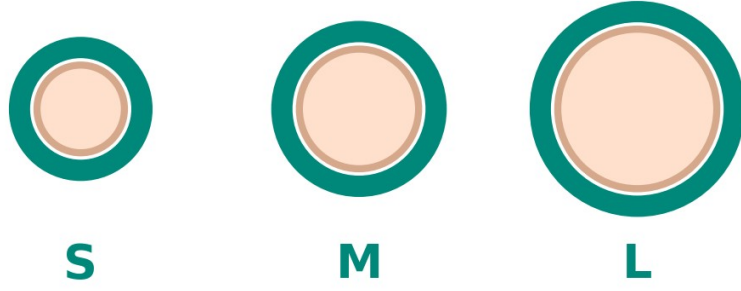
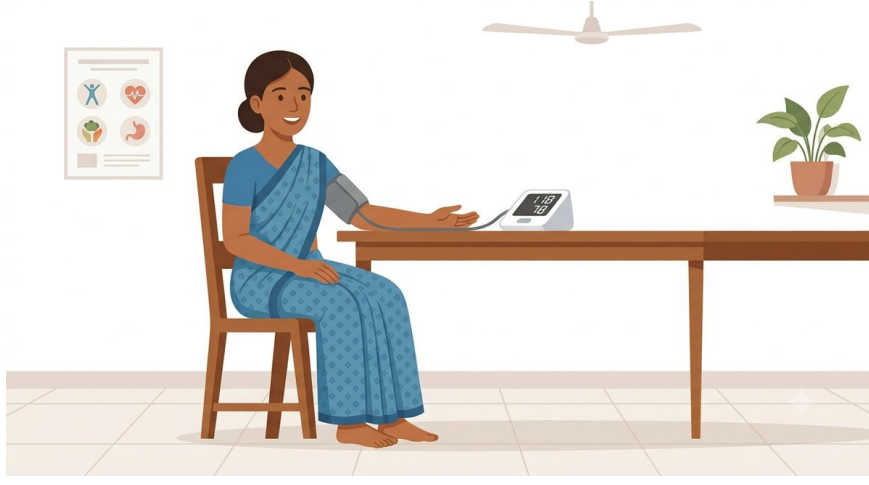
H-03 | All

ඔබේ රුධිර පීඩන අගයන් (සියලුදෙනා)

உங்கள் இரத்த அழுத்த அளவுகள் (எல்லோரும்)

කියවීම	ක්‍රියාමාර්ගය
140/90 ට අඩු	සාමාන්‍යයි. රුධිර පීඩන වැඩිලටි ගන්නේ නම් ඉලක්කය 135/85 හෝ ඊට අඩුයි.
140/90 හෝ ඊට වැඩි	එදිනම ඔබේ සායනයට දන්වන්න
160/110 හෝ ඊට වැඩි, හෝ අනතුරු ඇඟවීමේ ලක්ෂණයක් (H-07)	දැන්ම රෝහලට එන්න

- ප්‍රතිකාර ඉලක්කය: 135/85. ඔබේ සායනය වෙනත් ඉලක්කයක් දිය හැක. මෙහි ලියන්න: _____



H-05 | All

இனெ லெஹை (ஃஸுரூதெனா)

உங்கள் மருந்துகள் (எல்லோரும்)

- ஃசுரூ தீதகம ஸ்தீத. ஃதீபெத ஃபீயசீ, தவநீதவநீத மஃ ஸரீதீதவநீத ஃபா.
- ஸரீதீ: ஃமாத்மயெதீ ரூவெலூதீ, தீரெவீதீ ஃத மெநீலீவெஃபா ஸாபீதா கரதீ. மெநீலீவெஃபா தீஃ தீதீத அநீ ஃய ஸக.
- ஸரீதீஸாபயெதீதீ ஃரக்தீக தோவத லெஹை: ஃதரூதீ, ரூஃபா, அமரூவீதீ. ஃபா ஸ்தீதா அநரீ ஸூ ஸநீகா, ஸீ ஸூ ஸூதீம ஃரூதீ கரதீதீ தம, வஸாம இனெ ஃயதயம யதீத.
- ஃதீதீயெதீ ஃத இனெ ஃயதய வூலீவெலீ வெதீ கரூ ஸக. கரீ தீமெதீ ஃரக்தீக ஃபா மோதவாதுதீ அதீத.
- இனெ அதுதீ நீனெ தம, இனெ ஃதீகார கரத ஃசுரூ கீயதீத. அதுதீ அநீ அய ஃதீத ரூவெலூதீ வூதீதீய யுதுதீ.
- வெதீதா தாஃக: ஃரூதீவெலூதீ ஸாபீதா கரதீத. வீதீதீரூதீதீ வூதீ ஃபா இனெ ஃயதய கீயதீதீ தம மீத வூதீதீத.
- ஃதீதீ ஃரூதீ ஃதீ ஃத ஸீதீதீ ஃதீகார ரூதீதீ தீதய ஃதீத தீதீ ஸக. ஃதீதீ ஸூதீம ஃதீ இனெ அமீ ரூதீதீ தீதய அநீ வெ இனெ ஃயதயம கீயதீத.

- தீதீதீதீ எடுதீதீ, நலமாத உணரீதீதீதீதீ. நீதீதீதீதீதீ தவறவீதீதீதீ வேணீதீதீ.
- கரீதீதீதீ: ஃதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீ, நீதீதீதீதீதீ, மெதீதீதீதீதீதீ. மெதீதீதீதீதீதீ தூதீதீதீ கலதீதீதீ தரலாம.

- கர்ப்பத்தில் பாதுகாப்பற்றவை: எனலாப்ரில், லோசார்டன், அம்லோடிபின். இவற்றை எடுக்கும்போது கர்ப்பமானாலோ, கர்ப்பமாகத் திட்டமிட்டாலோ உடனே உங்கள் கிளினிக்கைப் பாருங்கள்.
- பிரசவத்திற்குப் பின் உங்கள் கிளினிக் மாத்திரையை மாற்றலாம். தாய்ப்பாலூட்டும்போது எவை பாதுகாப்பானவை என்று கேளுங்கள்.
- உங்களுக்கு ஆஸ்துமா இருந்தால், உங்களுக்குச் சிகிச்சை அளிப்பவர் அனைவரிடமும் சொல்லுங்கள். ஆஸ்துமாவில் லபெடலாலத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- வலி நிவாரணிகள்: பாரசிட்டமால் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் கிளினிக் கூருவிட்டால் டைக்ளோஃபெனாக் போன்றவற்றைத் தவிர்க்கவும்.
- கருத்தடை மாத்திரை, ஹார்மோன் சிகிச்சை இரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்தலாம். தொடங்குவதற்கு முன் உங்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் இருப்பதை உங்கள் கிளினிக்கிற்குச் சொல்லுங்கள்.

H-06 | All

உணவும் வாழ்க்கை முறையும் (எல்லோரும்)

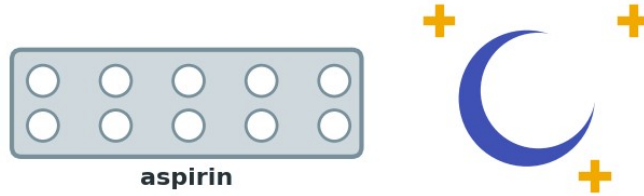
- உப்பைக் குறையுங்கள். கருவாடு, உப்புமீன், ஊறுகாய், அப்பளம், சிப்ஸ், இன்ஸ்டன்ட் நூடில்ஸ், ஸ்டாக் கியூப் ஆகியவற்றைக் குறைக்கவும்.
- மேசை உப்பைச் சேர்க்க வேண்டாம்.
- பழங்களும் காய்கறிகளும் அதிகம்.
- சரியான எடை (அத்தியாயம் 5). தினமும் நடக்கவும்.
- புகைபிடித்தல், மது, புகையிலை போட்ட வெற்றிலை வேண்டாம்.
- கர்ப்பிணி: இடது பக்கமாகச் சாய்ந்து ஓய்வெடுங்கள்.

ඇස්පிரீன் (ஹார்னி, நியம் கல பிவ)

ஆஸ்பிரின் (கர்ப்பிணி, பரிந்துரைத்தால்)

- ஸ்மோர் காத்நாவன் ஸ்ரீ-லக்ஷ்மிச்சியா வீமே ஈபததம் ஈபு கிரீமம் ஹர்ஹீலாவயே மூல ஸிம் ராக் ரீமம் ஈபு மானாவே ஈபுஸ்பிரீன் லொ டே.
- ஓலம் லியா டீ ஈகி மானாவ ணீன்.
- ஓலம் ஈபும, ஈபுஸ்பிரீன் ஹீ ஈலாவயே ஈபுலா கிவீ னலி, ஹீ வேதனா னாவகயகித் ஸ்ரீகிரியாவகி ஸ்ரீ ஈபுஸ்பிரீன் ஓலீ ஸாயநயம் கியநீன்.

- சில பெண்களுக்கு ப்ரீ-எக்லாம்ப்ஸியா வரும் வாய்ப்பைக் குறைக்க ஆரம்பக் கர்ப்பத்திலிருந்து இரவில் குறைந்த அளவு ஆஸ்பிரின் தரப்படும்.
- உங்களுக்கு எழுதித் தரப்பட்ட அளவை எடுங்கள்.
- உங்களுக்கு ஆஸ்துமா, இரைப்பை அழற்சி அல்லது வயிற்றுப் புண் இருந்தால், அல்லது ஒரு வலி நிவாரணியால் எதிர்வினை ஏற்பட்டிருந்தால் உங்கள் கிளினிக்கிற்குச் சொல்லுங்கள்.



புபுனியேன் பபு (ஹார்னி)

பிரசவத்திற்குப் பின் (கர்ப்பிணி)

- பபுனியேன் டீரீர் பீவநய ஓபல ஸா னக.
- ப்ரீலிவ ணீனீ னலி ஸகி 1-2 கடீ னலவ பரீகீலா கரநீன். ஸூம் கெநைகூம் ஸகி 6 கடீ னலவ பரீகீலா கிரீமம் ஈபும வீ. மல னாவரீன்.
- பீவநாய் டீவா வாகரீக டீரீர் பீவந பரீகீலாவ. ஹர்ஹீலாவயே ஈபு டீரீர் பீவநய கிவ் காத்நாவன் பபு ஈபு டீரீர் பீவநய ப்ரீலிவ ஈபுததம் ப்ரீவீ.
- ரீலவ ஹர்ஹீலாவ: கலீன் ஸாயநயம் கியநீன்.

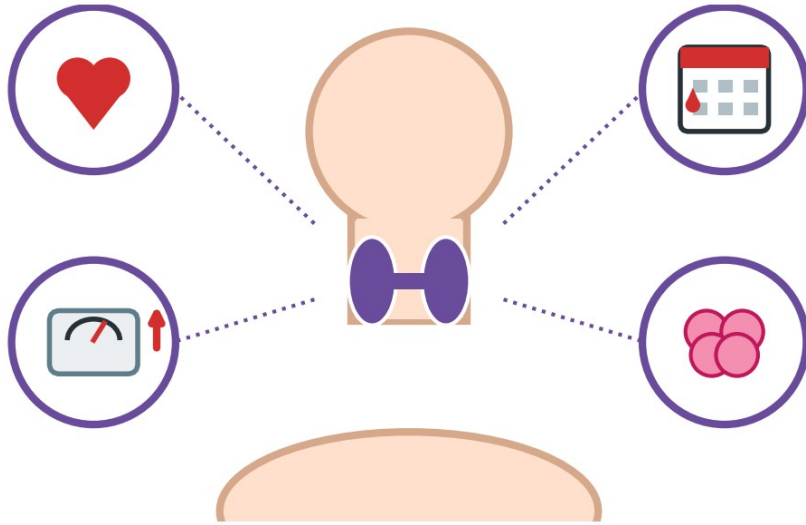
- முதல் வாரத்தில் இரத்த அழுத்தம் உயரலாம்.
- மாத்திரை எடுத்தால் 1-2 வாரங்களில் மீள்பரிசோதனை. எல்லோருக்கும் 6 வாரங்களில் மீள்பரிசோதனை. தவறவிடாதீர்கள்.
- வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் இரத்த அழுத்தப் பரிசோதனை. கர்ப்பத்தில் உயர் இரத்த அழுத்தம் இருந்த பெண்களுக்குப் பின்னர் உயர் இரத்த அழுத்தம் வரும் வாய்ப்பு அதிகம்.
- அடுத்த கர்ப்பம்: முன்கூட்டியே கிளினிக்கைப் பாருங்கள்.

පරිච්ඡේදය 3: තයිරොයිඩ් රෝග அத்தியாயம் 3: தைராய்டு நோய்கள்

T-01 | All

තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය යනු කුමක්ද? (සියලුදෙනා)
தைராய்டு என்றால் என்ன? (எல்லோரும்)

- බෙල්ලේ ඉදිරිපස ඇති කුඩා ග්‍රන්ථියකි.
 - එය ශක්තිය, හදවතේ වේගය, බර, ඔසප් සහ මනෝභාවය සඳහා බලපාන තයිරොයිඩ් හෝමෝනය නිපදවයි.
 - ගෝර්ණ්භාවයේදී එය ඔබේ දරුවාගේ මොළයේ වධර්නයටද අත්‍යවශ්‍යයි.
 - ගැටලු දෙකකි: අඩුවෙන් ක්‍රියා කිරීම සහ වැඩියෙන් ක්‍රියා කිරීම.
- කழுத்தின் முன்புறத்தில் உள்ள சிறிய சுரப்பி.
 - இது சக்தி, இதயத் துடிப்பு, எடை, மாதவிடாய், மனநிலை ஆகியவற்றுக்கான தைராய்டு ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்கிறது.
 - கர்ப்பத்தில் இது உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கும் அவசியம்.
 - இரண்டு பிரச்சினைகள்: குறைவாகச் சுரத்தல் மற்றும் அதிகமாகச் சுரத்தல்.



T-02 | All

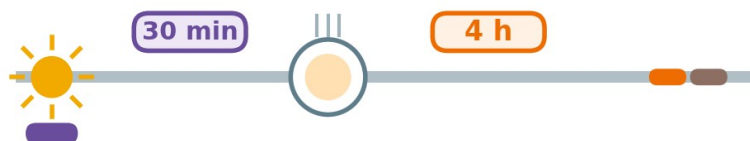
අඩුවෙන් ක්‍රියා කරන තයිරොයිඩ් (සියලුදෙනා)
குறைவாகச் சுரக்கும் தைராய்டு (எல்லோரும்)

- ලක්ෂණ: තෙහෙට්ටුව, සීතල දැනීම, බර වැඩිවීම, මලබද්ධය, වියළි සම, කෙස් ගැලවීම, පහත් මනෝභාවය, අධික හෝ අක්‍රමවත් ඔසප්.

- ගහර්ණිභාවයේදී, ප්‍රතිකාර නොකළහොත්: ගබ්සාව, කල් නොපිරී උපත සහ දරුවාගේ මොළයේ දූවර්ල වධර්නය.
- ගහර්නී නොවන කාන්තාවන්ගේදී: ඔසප් සහ ගැබ් ගැනීමේ ගැටලු.
- ප්‍රතිකාර කිරීම පහසුයි.

கடெரோக்ஸித் (ஓலோகடெரோக்ஸித்) ௮௩௭௮ (பிடிபுடினா)
தைராக்கின் (லெவோதைராக்கின்) மாத்திரைகள் (எல்லோரும்)

- දිනපතා එකම වේලාවට එක් වැඩිලියකි.
- අවදි වූ විගස, හිස් බඩින්, වතුරත් සමඟ. තේ, කිරි හෝ ආහාරවලට පෙර මිනිත්තු 30 ක් රැඳී සිටින්න.
- යකඩ සහ කැල්සියම් වැඩිලි පැය 4 ක් ඇතිත් ගන්න.
- සනීපයක් දැනුණු පමණින් නවත්වන්න එපා.
- ගහර්ණිභාවයේදී සහ කිරි දීමේදී ආරක්ෂිතයි.



ප්‍රසූතියෙන් පසු (ගහර්තී)

பிரசவத்திற்குப் பின் (கர்ப்பிணி)

- සමහර කාන්තාවන්ට පළමු වසර තුළ තයිරොයිඩ් ගැටලු ඇති වේ. බොහෝවිට කෙහෙට්ටුව හෝ "බේබි බ්ලූස්" ලෙස වරදවා වටහා ගැනේ.
- ඔබේ සායනයට කියා TSH පරීක්ෂාවක් ඉල්ලන්න.
- ශ්‍රේවස් රෝගය නැවත වධර්තය විය හැක. සති 6 කදී නැවත පරීක්ෂාව.
- වාෂරීක TSH පරීක්ෂාව.

- சில பெண்களுக்கு முதல் ஆண்டில் தைராய்டு பிரச்சினைகள் வரும். பெரும்பாலும் சோர்வு அல்லது "பேபி புளூஸ்" என்று தவறாகக் கருதப்படும்.
- உங்கள் கிளினிக்கிற்குச் சொல்லி TSH பரிசோதனை கேளுங்கள்.
- கிரேவ்ஸ் நோய் மீண்டும் தீவிரமடையலாம். 6 வாரங்களில் மீள்பரிசோதனை.
- ஆண்டுதோறும் TSH பரிசோதனை.



නාරිවේද කාන්තාවන්ගේ තයිරොයිඩ් (ගහර්තී නොවන)

மகளிர் நோய் கிளினிக் பெண்களில் தைராய்டு (கர்ப்பமில்லாதவர்)

- අඩුවෙන් සහ වැඩියෙන් ක්‍රියා කරන තයිරොයිඩ් දෙකම ඔසප් වෙනස් කරයි (අධික, අඩු හෝ නොපැමිණීම) සහ ගැබ් ගැනීම දුෂ්කර කළ හැක.
- ඔසප් වෙනස් වුවහොත් හෝ හේතුවක් නැතිව බර වැඩි/අඩු වුවහොත් ඔබේ සායනයට කියන්න.
- ඔසප් නැවතීමේ සහ තයිරොයිඩ් ලක්ෂණ එකිනෙකට සමානයි. රුධිර පරීක්ෂාවෙන් වෙන්කර දැනගත හැක.
- ශල්‍යකර්මයට පෙර: ඔබේ බෙහෙත් ගෙන එන්න. තයිරොක්සීන් සුපුරුදු පරිදි ගන්න.
- ගැබ් ගැනීමට සැලසුම් කරනවාද? පළමුව ඔබේ සායනය බලන්න.

- குறைவாகவும் அதிகமாகவும் சுரக்கும் தைராய்டு இரண்டும் மாதவிடாயை மாற்றும் (அதிகம், குறைவு அல்லது நின்றுபோதல்) மற்றும் கருத்தரிப்பைக் கடினமாக்கலாம்.
- மாதவிடாய் மாறினாலோ, காரணமின்றி எடை கூடினாலோ குறைந்தாலோ உங்கள் கிளினிக்கிற்குச் சொல்லுங்கள்.
- மாதவிடாய் நிறுத்த அறிகுறிகளும் தைராய்டு அறிகுறிகளும் ஒன்றுபோல் இருக்கும். இரத்தப் பரிசோதனை அவற்றைப் பிரித்துக் காட்டும்.

- அறுவைச் சிகிச்சைக்கு முன்: உங்கள் மருந்துகளைக் கொண்டுவாருங்கள். தைராக்சினை வழக்கம்போல எடுங்கள்.
- கர்ப்பமாகத் திட்டமிடுகிறீர்களா? முதலில் உங்கள் கிளினிகைப் பாருங்கள்.



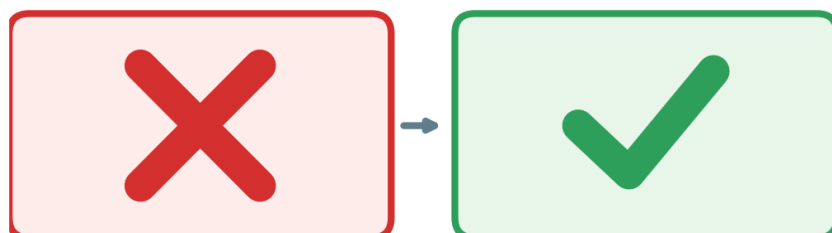
T-09 | All

මිථ්‍යා සහ සත්‍ය (පියලුදෙනා)

கட்டுக்கதைகளும் உண்மைகளும் (எல்லோரும்)

මිථ්‍යාව	සත්‍යය
"තයි‍රොයිඩ් වැඩිලට් දරුවාට හානි කරයි."	ප්‍රතිකාර නොකළ තයි‍රොයිඩ් දරුවාට හානිකරයි. වැඩිලට් ආරක්ෂිතයි.
"මට සනීපයි, නවත්වන්න පුළුවන්."	ඔබේ සායනය කියන විට පමණක් නවත්වන්න.
"අමතර අයඩින් මෙය සුව කරයි."	අයඩින් යෙදූ ලුණු භාවිතා කරන්න. අමතර අයඩින් හානිකර විය හැක.
"තයි‍රොයිඩ් රෝගයක් සමඟ කිරි දෙන්න බැ."	ඔබට කිරි දිය හැක.

கட்டுக்கதை	உண்மை
"தைராய்டு மாத்திரைகள் குழந்தைக்குத் தீங்கு செய்யும்."	சிகிச்சையில்லாத தைராய்டே குழந்தைக்குத் தீங்கு. மாத்திரைகள் பாதுகாப்பானவை.
"எனக்கு நலமாக இருக்கிறது, நிறுத்திவிடலாம்."	உங்கள் கிளினிக் சொல்லும்போது மட்டும் நிறுத்துங்கள்.
"கூடுதல் அயோடின் இதைச் சரிசெய்யும்."	அயோடின் கலந்த உப்பைப் பயன்படுத்துங்கள். கூடுதல் அயோடின் தீங்கு தரலாம்.
"தைராய்டு நோய் இருந்தால் தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியாது."	நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம்.

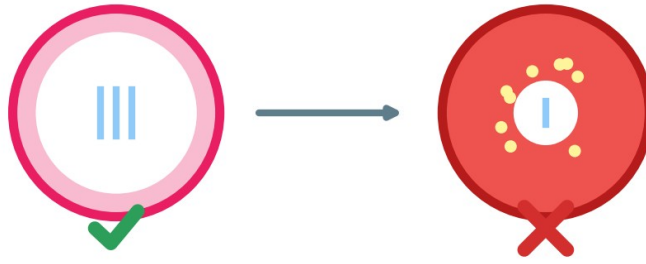


පරිච්ඡේදය 4: ඇදුම அத்தியாயம் 4: ஆஸ்துமா

A-01 | All

ඇදුම යනු කුමක්ද? (සියලුදෙනා)
ஆஸ்துமா என்ன? (எல்லோரும்)

- දිගුකාලීන රෝගයකි. හුස්ම නාල ඉදිමී පටු වේ.
- ලක්ෂණ: කැස්ස (බොහෝවිට රාත්‍රියේදී), හුස්ම හඩ (විසිල් ගබ්දය), හුස්ම හිරවීම, පපුවේ තදබව.
- උත්තේජක: දූවිලි, දුම, සිතලි වාතය, ආසාදන, තද ගඳ, වායාම.
- நீண்டகால நோய். சுவாசக் குழாய்கள் வீங்கிச் சுருங்கும்.
- அறிகுறிகள்: இரும்பல் (பெரும்பாலும் இரவில்), மூச்சிரைப்பு (விசில் சத்தம்), மூச்சுத் திணறல், நெஞ்சு இறுக்கம்.
- தூண்டுதல்கள்: தூசி, புகை, குளிர்காற்று, தொற்றுகள், கடும் நெடி, உடற்பயிற்சி.



A-02 | P

ඇදුම සහ ගහර්ණීභාවය (ගහර්නී)
ஆஸ்துமாவும் கர்ப்பமும் (கர்ப்பிணி)

- ඇදුම ඇති බොහෝ කාන්තාවන්ට නිරෝගී ගහර්ණීභාවයක් ඇත.
- ඇදුම හොඳ වීමට, තරක වීමට හෝ එසේම පැවතීමට පුළුවන්.
- පාලනය නොකළ ඇදුමයි අනතුර. දරුවාට ඔක්සිජන් අඩු වේ.
- ඇදුම බෙහෙත් ගහර්ණීභාවයේදී සහ කිරි දීමේදී ආරක්ෂිතයි. ප්‍රතිකාර නොකළ ඇදුමේ අවදානම වැඩිය.
- ஆஸ்துமா உள்ள பெரும்பாலான பெண்களுக்கு ஆரோக்கியமான கர்ப்பம் அமையும்.
- ஆஸ்துமா குறையலாம், அதிகரிக்கலாம் அல்லது அப்படியே இருக்கலாம்.
- கட்டுப்படுத்தப்படாத ஆஸ்துமாவே ஆபத்து. குழந்தைக்கு ஆக்சிஜன் குறையும்.
- ஆஸ்துமா மருந்துகள் கர்ப்பத்திலும் தாய்ப்பாலூட்டும்போதும் பாதுகாப்பானவை. சிகிச்சையில்லாத ஆஸ்துமாவின் ஆபத்தே அதிகம்.

A-03 | All

இலி ஒதீஹீலர் டேக (ஃயுலுடேதா)

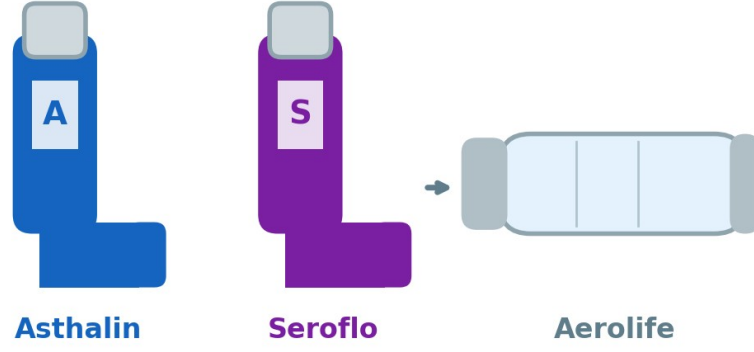
உங்கள் இரண்டு இன்ஹேலர்கள் (எல்லோரும்)

	Asthalin (ஃபன டேத - RELIEVER)	Seroflo (புலுவுத - PREVENTER)
கூயா கரத ஂகாரய	புஃத நாட ஒகீததீன் பீபர கரதீ	ஒஃதீத ஃதீபுதீன் கரதீ (ஃத கதீபயகதீன் கூயா கரதீ)
கபடட	லுஃதீத ஂகதீ பீத பதீதீ	ஃதீத ஃதீதீத, ஂடே ஃத ஃதீத, ஃதீதீதீ ஃதீதீதீ
இலி லாபூப	ஃதீதீத பீத ____ பதீ	ஂடே ஃத ஃதீத ____ பதீ
பாபீதயதீத பஃபு		கத ஃதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீ
பதீதீத	தீதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீ	ஃதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீ

- "தீதீத Asthalin = பூபாரய. ஃதீத Seroflo = ஃதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீ."
- டேகதீத Aerolife ஃதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீ.
- Seroflo பூபாரயகீ தபதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீ.

	Asthalin (தீவாரணீ - RELIEVER)	Seroflo (தடுப்பான் - PREVENTER)
வேலீல	கவாசகீ குழாய்கதீள விரைவாகதீ தீதீதீதீதீதீதீதீதீதீதீ	வீகீதீ (கீல நாட்களீதீ)
எப்போது	ஂதீ	தீ
உங்கள் ஂளவு	தீ	காலை, மாலை ____ பதீதீ
பயன்படுதீ		வாயைகீ கதாப்பளீதீ
தீ	தீ	ஂதீ

- "தீதீத Asthalin = தாக்குதலீதீ
- இரண்டுதீ
- Seroflo தாக்குதலீதீ



A-04 | All

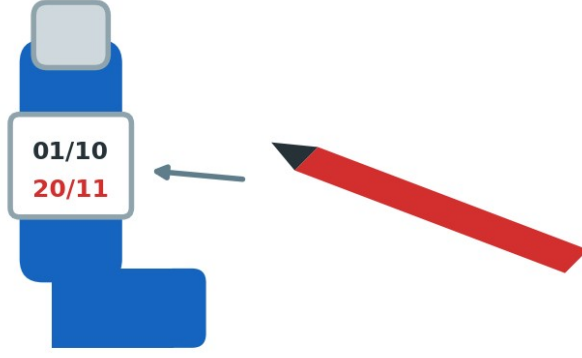
சீசேசர்ய ஸமஹ ஓந்ஹேரேய ஹாவிகா கிரீம (பிசுலுடேனா) ஸ்பேசருடன் இன்ஹேலரைப் பயன்படுத்தும் முறை (எல்லோரும்)

1. பிசுத ஓவக் கரந்த. ஓந்ஹேரேய ஸோலவந்த.
2. லீய சீசேசர்யஃ ஸவீ கரந்த.
3. கெலித் பிடி ஹே ஃஃ ஓந். பூஸ்த பிஃகரந்த.
4. மூவ கஹஃய லஃ ஐவெ கஹலீ கடி கரஓந்த.
5. லக் பரீ லக் பஃசுக் ல்வந்த.
6. ஸெமீத் ஓலூரீத் பூஸ்த ஓந். கந்பர 10 க் பூஸ்த ரடிவா ஓந். *நானஹாத் சீசேசர்ய ஹரஹ ஸெமீத் 5 லவாவக் பூஸ்த ஓந் பிஃகரந்த.*
7. கவக் பரீ லக் ஃவஓடி? கந்பர 30-60 க் டீஃபிவந்த. நாவக ஸோலவந்த. லக்வர லக் பரீ லக் பஃசு.
8. Seroflo பஃசு: கஃ ஸோடி கெல ஓஸந்த.
 - டேகஃ ஹாவிகா கரந்தத் நஃ: மூலீத் Asthalin, மீநீக் 5 கஃ பஃ Seroflo.
 - ஃலூக் ஓந்ஹேரேயக் ஹே ஃலூ காலயக் ஹாவிகா நஹகல லக்: மூலீத் லாகயஃ லக் வரக் ஹே டேவரக் ஓஃந்த (பஃகாவெ ஸடிஹத் பரீடி).
 - ஓஓந்வத ஃயஃ: ஸூல பூலீசுமகஃஃ ஃயஃ லீய பஃந்வத லேஸ ஓலீலந்த.

1. மூடியை அகற்றுங்கள். இன்ஹேலரை குலுக்குங்கள்.
2. அதை ஸ்பேசரில் பொருத்துங்கள்.
3. நிமிர்ந்து உட்காருங்கள் அல்லது நில்லுங்கள். மூச்சை வெளியே விடுங்கள்.
4. வாய்ப்பகுதியைச் சுற்றி உதடுகளை இறுக்கமாக மூடுங்கள்.
5. ஓரே ஓரு பஃப் மட்டும் அழுத்துங்கள்.
6. மெதுவாக ஆழமாக உள்ளிழுங்கள். 10 விநாடி மூச்சை நிறுத்துங்கள். *அல்லது ஸ்பேசர் வழியாக மெதுவாக 5 முறை உள்ளிழுத்து வெளிவிடுங்கள்.*
7. இன்னொரு பஃப் தேவையா? 30-60 விநாடி காத்திருங்கள். மீண்டும் குலுக்குங்கள். ஓரு நேரத்தில் ஓரு பஃப் மட்டும்.
8. Seroflo மட்டும்: வாயைக் கொப்பளித்துத் துப்புங்கள்.
 - இரண்டையும் பயன்படுத்தினால்: முதலில் Asthalin, 5 நிமிடம் கழித்து Seroflo.

- புதிய இன்ஹேலர் அல்லது நீண்ட நாள் பயன்படுத்தாதது: முதலில் காற்றில் ஒன்றிரண்டு முறை தெளியுங்கள் (துண்டுப்பிரசுரத்தில் உள்ளபடி).
- கற்பிப்பவருக்கு: ஒவ்வொரு வருகையிலும் அவரைச் செய்து காட்டச் சொல்லுங்கள்.





$$\begin{array}{|c|} \hline 200 \\ \hline \text{puffs} \\ \hline \end{array} \div \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \text{per day} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 50 \\ \hline \text{days} \\ \hline \end{array}$$

A-06 | All

பிரிசுட்டி கிரீம் பயிற்சி (பிரிசுட்டி)

சுத்தம் செய்தலும் உலர்த்தலும் (எல்லோரும்)

பிரிசுட்டி (பிரிசுட்டி வரைவு):

1. பிசுட்டி வரைவு.
2. பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.
3. பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.
4. பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.

பிரிசுட்டி வரைவு (பிரிசுட்டி வரைவு):

1. பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.
2. பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.
3. பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.
- பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.

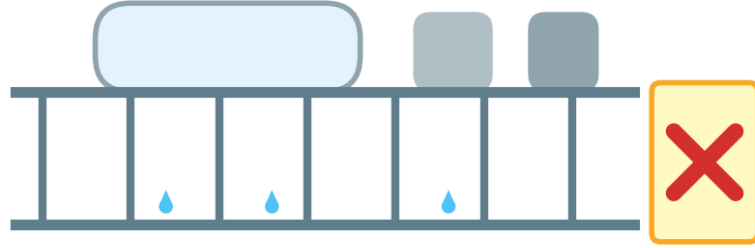
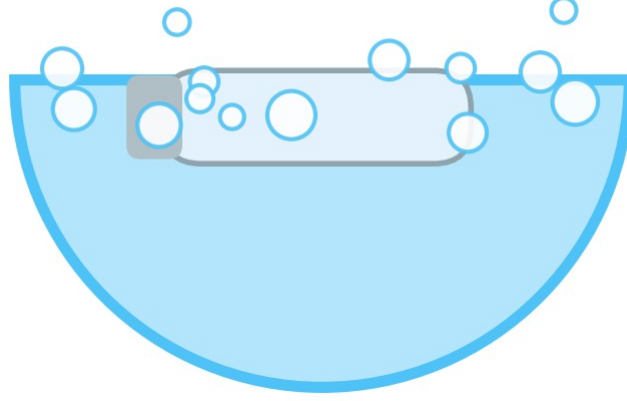
பிரிசுட்டி (வாரம் ஒருமுறை):

1. பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.
2. பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.
3. பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.
4. பிசுட்டி வரைவு விகிதம் 15 நிமிடம் வரைவு.

பிரிசுட்டி வரைவு (வாரம் ஒருமுறை):

1. உலோக டப்பாவை வெளியே எடுங்கள்.
 2. பிளாஸ்டிக் உறையை ஓடும் நீரில் கழுவுங்கள். டப்பாவை ஒருபோதும் தண்ணீரில் போடாதீர்கள்.
 3. உறையை உலர்த்தி, டப்பாவை மீண்டும் வையுங்கள்.
- ஸ்பேசரில் விரிசல் இருந்தால் மாற்றுங்கள்.

15 min

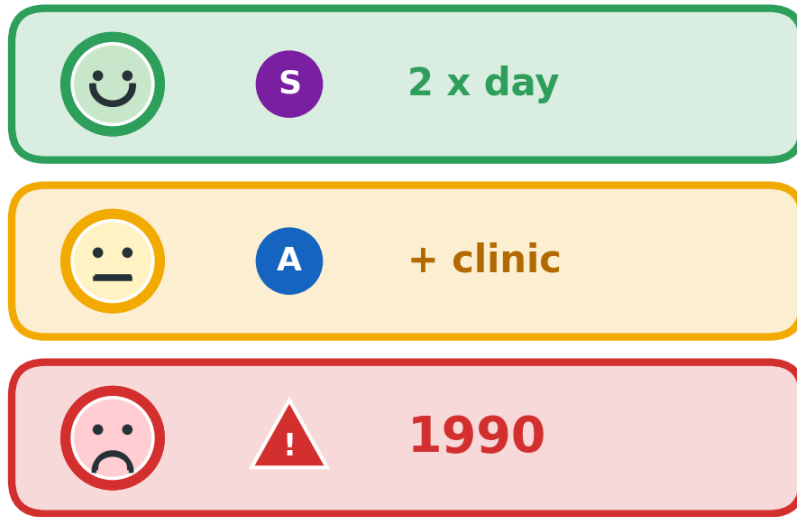


කලාපය	පිටිට දූෂණ ආකාරය	කළ යුත්තේ
කොළ	කැස්සක් හෝ හුස්ම හඬක් නැත	සෑම දිනකම Seroflo
කහ	කැස්ස, හුස්ම හඬ, පපුවේ තදබව, රාත්‍රියේ ඇහැරීම, සුපුරුදු ප්‍රමාණයට වඩා Asthalin අවශ්‍ය වීම	ස්පේසරයෙන් Asthalin. එදිනම සායනයට එන්න.
රතු	වාක්‍යයක් සම්පූර්ණ කළ නොහැක, තොල් නිල් වීම, Asthalin වලින් සහනයක් නැත, නිදිමත	රෝහලට යන අතරතුර Asthalin පත් එකින් එක. දැන්ම එන්න. 1990 අමතන්න.

- රතු කලාපයේදී ඔබම වාහනය පදවන්න එපා.

மண்டலம்	நீங்கள் உணர்வது	செய்ய வேண்டியது
பச்சை	இருமல் அல்லது மூச்சிரைப்பு இல்லை	தினமும் Seroflo
மஞ்சள்	இருமல், மூச்சிரைப்பு, நெஞ்சு இறுக்கம், இரவில் விழிப்பு, வழக்கத்தை விட அதிகமாக Asthalin தேவைப்படுதல்	ஸ்பேசர் வழியாக Asthalin . அதே நாளில் கிளினிக்கிற்கு வாருங்கள்.
சிவப்பு	வாக்கியத்தை முடிக்க முடியாது, உதடுகள் நீலமாதல், Asthalin ஆல் நிவாரணம் இல்லை, தூக்கக் கலக்கம்	மருத்துவமனைக்குச் செல்லும்போது Asthalin பஃப்களை ஒவ்வொன்றாக. உடனே வாருங்கள். 1990 ஐ அழையுங்கள்.

- சிவப்பு மண்டலத்தில் நீங்களே வாகனம் ஓட்ட வேண்டாம்.



A-08 | All

ඩබ්லிவ் උත්තේජක මහහරවා ගැනීම (සියලුදෙනා)
 உங்கள் தூண்டுதல்களைத் தவிர்த்தல் (எல்லோரும்)

උත්තේජකය	කළ යුත්තේ
දූවිලි, දූවිලි මයිටාවන්	කෙත රෙදිවලින් පිස දමන්න, වියළිව අතුගාන්න එපා. ඇඳ ඇතිරිලි සතිපතා සෝද, අවිච්චි වියළන්න.
දුම	ගෙදර දුම්පානය නැක. දර දුම, සුවඳ දුම්, මදුරු දුම් ගොට්ටු, කසල පුළුස්සීම වළක්වන්න.
කෙතමන සහ දිලීර	කාන්දු අලුත්වැඩියා කරන්න. කාමරයට වාතය ලබා දෙන්න.
සුරතල් සතුන් සහ කුරුල්ලන්	නිදන කාමරයෙන් පිටත තබන්න.
තද ගඳ	සුවඳ විලවුන්, තීන්ත, භූමිකෙල්, බිලිව, ස්ප්‍රේ වළක්වන්න.
සීතල වාතය	නාසය සහ මුඛය වසා ගන්න.
සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව සහ ෆ්ලූ	අත් සෝදන්න. සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවට කලින් ප්‍රතිකාර කරන්න.
වේදනා නාශක	ඇස්පිරින් සහ ඩයික්ලොෆෙනෙක් ඇදුම උත්තේජනය කළ හැක. පැරසිටමෝල් භාවිතා කරන්න.

தூண்டுதல்	செய்ய வேண்டியது
தூசி, தூசிப் பூச்சிகள்	ஈரத் துணியால் துடையுங்கள், உலர்ந்து கூட்டாதீர்கள். படுக்கை விரிப்புகளை

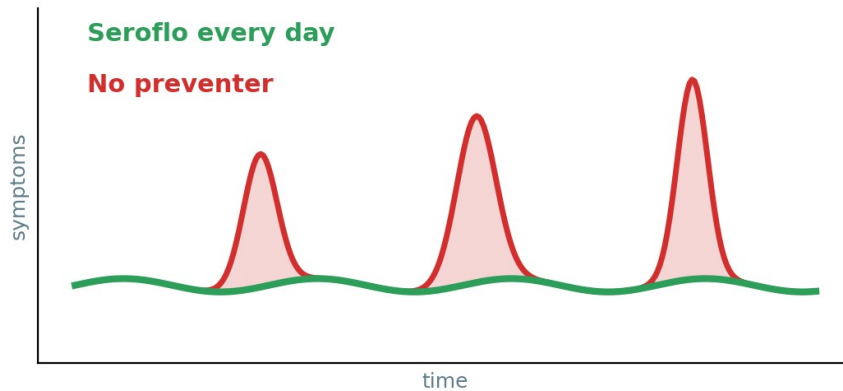
	வாரந்தோறும் துவைத்து வெயிலில் உலர்த்துங்கள்.
புகை	வீட்டில் புகைபிடிக்கக் கூடாது. விறகு அடுப்புப் புகை, ஊதுபத்தி, கொசுவர்த்திச் சுருள், குப்பை எரித்தல் ஆகியவற்றைத் தவிர்க்கவும்.
ஈரப்பதம், பூஞ்சை	கசிவுகளைச் சரிசெய்யுங்கள். அறையில் காற்றோட்டம் வையுங்கள்.
செல்லப் பிராணிகள், பறவைகள்	படுக்கையறைக்கு வெளியே வையுங்கள்.
கடும் நெடி	வாசனைத் திரவியம், பெயிண்ட், மண்ணெண்ணெய், ப்ளீச், ஸ்பிரே ஆகியவற்றைத் தவிர்க்கவும்.
குளிர்காற்று	மூக்கையும் வாயையும் மூடிக்கொள்ளுங்கள்.
சளி, காய்ச்சல்	கைகளைக் கழுவுங்கள். சளிக்கு முன்கூட்டியே சிகிச்சை எடுங்கள்.
வலி நிவாரணிகள்	ஆஸ்பிரின், டைக்ளோஃபெனாக் ஆஸ்துமாவைத் தூண்டலாம். பாரசிட்டமால் பயன்படுத்துங்கள்.



දිගුකாலීන පාලනය වැදගත් වන්නේ ඇයි (සියලුදෙනා) நீண்டகாலக் கட்டுப்பாடு ஏன் முக்கியம் (எல்லோரும்)

- **Seroflo** නිහඩව ක්‍රියා කරයි. එය ක්‍රියා කරන බව ඔබට නොදනේ.
- ඔබට සනීපයක් දැනුණත් හුස්ම නාළ ඉදිමී පවතී.
- ඔබ නැවැත්වුවහොත් ප්‍රහාරයක් ඇති විය හැක.
- හොඳ පාලනය: අඩු ප්‍රහාර, හොඳ නින්ද, සහ ගහර්ණිභාවයේදී දරුවාට වැඩි ඔක්සිජන්.
- ස්ටෙරොයිඩ් ඉන්හේලර් භාවිතා කරන්නේ ඉතා කුඩා මාත්‍රාවකි, එය ස්ටෙරොයිඩ් වැබ්ලටවලට වඩා බෙහෙවින් වෙනස්.
- **Asthalin** වැඩිපුර අවශ්‍ය වීම අනතුරු ඇඟවීමකි. සායනයට එන්න.

- **Seroflo** අමෙමතියාක වේලය සෙව්කිරිනු. අනු වේලය සෙව්වනු දරුවාට දෙරියානු.
- තලමාක දණර්තනාලුම සව්වසක් කුමාර්කල් වර්තකියේ ඉරුකුම.
- තිරුත්තිනල් තාකුතල් වරලාම.
- තල්ල කட்டுප්පාඩු: කුරෙව්වන තාකුතල්කල්, තල්ල තුරුකම්, කර්ප්පත්තිල් කුමර්තෙකුට අතික ආකුසිකුන්.
- ස්වරාය්ටු ඉන්ද්‍රෙවර්කල් මිකස් සිරිත අලවේ, අවේ ස්වරාය්ටු මාත්තිරෙකලිලිරුත්තු මිකවුම වේරුප්ප්වේ.
- **Asthalin** අතිකම් තේවේප්ප්වනු ආස්සරිකේ. කිලිනිකිරිකු වාරුරුකල්.



ප්‍රසූතිය, ශල්‍යකර්ම සහ කිරි දීම (ගහර්නී, ගහර්නී නොවන) பிரசவம், அறுவைச் சிகிச்சை, தாய்ப்பாலூட்டல் (கர்ப்பிணி, கர்ப்பமில்லாதவர்)

- ඔබේ ඉන්හේලර් සහ ස්පේසරය රෝහලට රැගෙන එන්න.
- ශල්‍යකර්මයට පෙර ඇතුළුව, ඔබට ඇදුම ඇති බව ඔබ රැකබලා ගන්න සැමට කියන්න. ප්‍රසූතියේදී සහ ශල්‍යකර්මවලදී භාවිතා කරන සමහර බෙහෙත් ඇදුම උත්තේජනය කළ හැක.
- ශල්‍යකර්මයට පෙර සහ පසුවද ඔබේ ඉන්හේලර් භාවිතා කරන්න.
- සියලුම ඇදුම ඉන්හේලර් කිරි දීමේදී ආරක්ෂිතයි.

- உங்கள் இன்ஹேலர்களையும் ஸ்பேசரையும் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுவருங்கள்.
- அறுவைச் சிகிச்சைக்கு முன் உட்பட, உங்களைக் கவனிப்பவர்கள் எல்லோரிடமும் உங்களுக்கு ஆஸ்துமா இருப்பதைச் சொல்லுங்கள். பிரசவத்திலும் அறுவைச் சிகிச்சைகளிலும் பயன்படுத்தும் சில மருந்துகள் ஆஸ்துமாவைத் தூண்டலாம்.
- அறுவைச் சிகிச்சைக்கு முன்னும் பின்னும் உங்கள் இன்ஹேலர்களைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துங்கள்.
- எல்லா ஆஸ்துமா இன்ஹேலர்களும் தாய்ப்பாலூட்டும்போது பாதுகாப்பானவை.



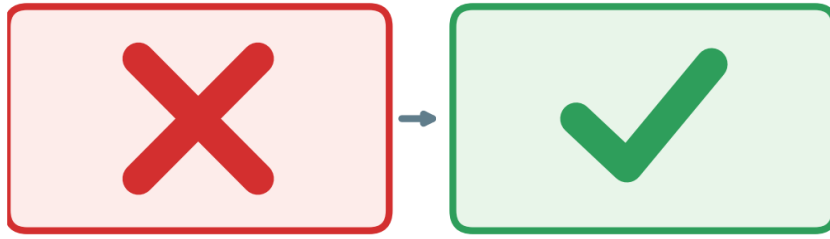
A-11 | All

தேர்வுப் பரீட்சை (பின்புலம்)

கட்டுக்கதைகளும் உண்மைகளும் (எல்லோரும்)

தேர்வுப் பரீட்சை	பின்புலம்
"ஃபெரோடெவி ஓன்லீட் மெட் டீர்டாப் ஹி கர்டி."	பாலைய நோக்கி அடிமேல் அறையு. மூலம் ஓகா கிடாதி.
"ஓன்லீட் அலீலி கர்டி."	நா.
"ஃபிசு வு லிப் நலன்லன் பூலி."	அடிமேல் டீனசகா பாலையக் அலமே.
"ரேல்டர் பக வுலிபூர ஹலி கிரே கலக் நா."	பிச அறையு அலலிமகி. ஃபாயசப் பினை.

கட்டுக்கதை	உண்மை
"ஸ்டிராய்டு இன்ஹேலர்கள் என் குழந்தைக்குத் தீங்கு செய்யும்."	கட்டுப்படுத்தப்படாத ஆஸ்துமாவே ஆபத்து. அளவு மிகச் சிறியது.
"இன்ஹேலர்கள் பழக்கமாகிவிடும்."	இல்லை.
"நலமானதும் நிறுத்திவிடலாம்."	ஆஸ்துமாவுக்குத் தினசரிக் கட்டுப்பாடு தேவை.
"நிவாரணியை அதிகம் பயன்படுத்துவது பரவாயில்லை."	அது ஒரு எச்சரிக்கை. கிளினிக்கிற்கு வாருங்கள்.



පරිච්ඡේදය 5: කරබාරුකම සහ නිසි බර

அத்தியாயம் 5: உடல் பருமனும் ஆரோக்கிய எடையும்

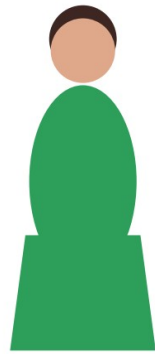
O-01 | All

කරබාරුකම යනු කුමක්ද? (සියලුදෙනා)

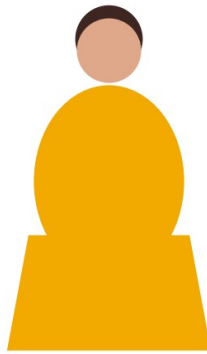
உடல் பருமன் என்றால் என்ன? (எல்லோரும்)

- ඔබේ සෞඛ්‍යයට වඩා වැඩි ශරීර මේදයක් තිබීමයි.
- BMI සහ ඉහටියේ වට ප්‍රමාණයෙන් මනිනු ලැබේ.
- දකුණු ආසියානු කාන්තාවන්ට අඩු BMI අගයකදී සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වන බැවින් ආසියානු සීමාවන් භාවිතා කෙරේ.

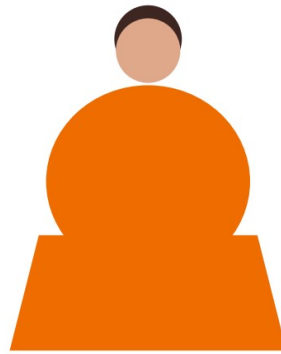
- உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்குத் தேவைக்கு அதிகமான உடல் கொழுப்பு இருப்பது.
- BMI மற்றும் இடுப்பளவால் அளக்கப்படும்.
- தென்னாசியப் பெண்களுக்குக் குறைவான BMI இலேயே உடல்நலப் பிரச்சினைகள் தொடங்குவதால் ஆசிய எல்லைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



18.5-22.9



23-24.9



25 +

O-02 | All

ඔබේ BMI (සියලුදෙනා)

உங்கள் BMI (எல்லோரும்)

BMI = බර (kg) / උස (m) / උස (m). උදාහරණය: 68 kg, 1.55 m: 68 / 1.55 / 1.55 = 28.3.

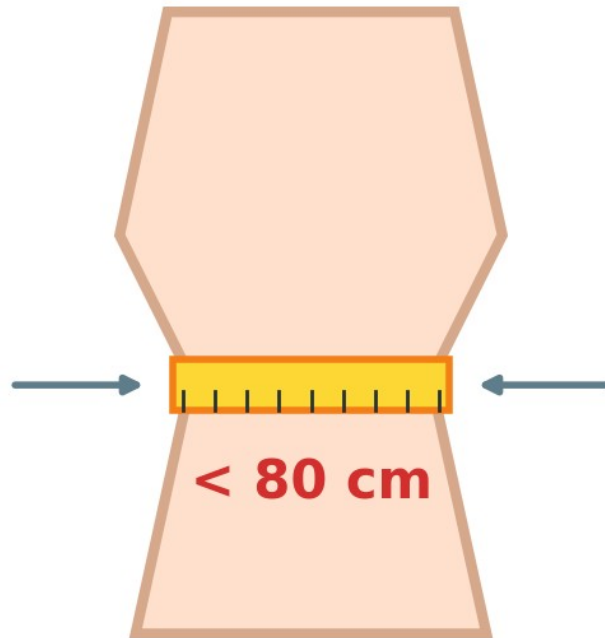
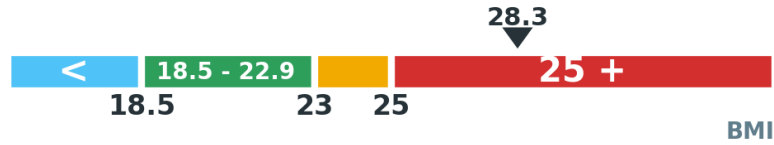
BMI	කාණ්ඩය (ආසියානු සීමාවන්)
18.5 ට අඩු	අඩු බර
18.5 සිට 22.9 දක්වා	නිරෝගී
23 සිට 24.9 දක්වා	අධි බර
25 හෝ ඊට වැඩි	කරබාරු

- காத்காவன்து ஓஃரீய ஃபன்தீரீர 80 ஃபீ ரீவ வுடீ நலீ ஂவதநல வுடீய. (ஃபரீஃஃலாவடீதீ நுலுநீ.)
- ஃபரீஃஃலாவடீதீ BMI ஃஃனய கரந்து ஃலு பஃலு பூரீஃஃலு ஃலுநீ.

BMI = எடல (kg) / உயரம் (m) / உயரம் (m). எடுத்துக்காட்டு 68 kg, 1.55 m: 68 / 1.55 / 1.55 = 28.3.

BMI	வகை (ஆசிய எல்லைகள்)
18.5 க்குக் குறைவு	எடல குறைவு
18.5 முதல் 22.9 வரை	ஆரோக்கியம்
23 முதல் 24.9 வரை	அதிக எடல
25 அல்லது அதற்கு மேல்	உடல் பருமன்

- பெண்களுக்கு இடுப்பளவு 80 செ.மீ. அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால் ஆபத்து அதிகம். (கர்ப்பத்தில் அளக்கப்படுவதில்லை.)
- கர்ப்பத்தில், BMI உங்கள் முதல் வருகையின் எடையிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது.

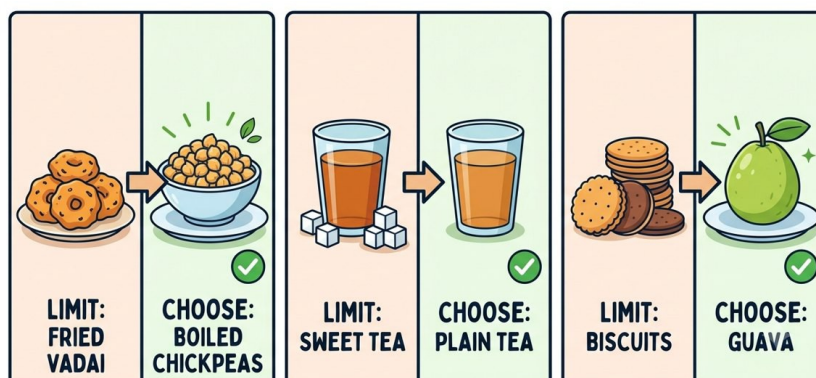
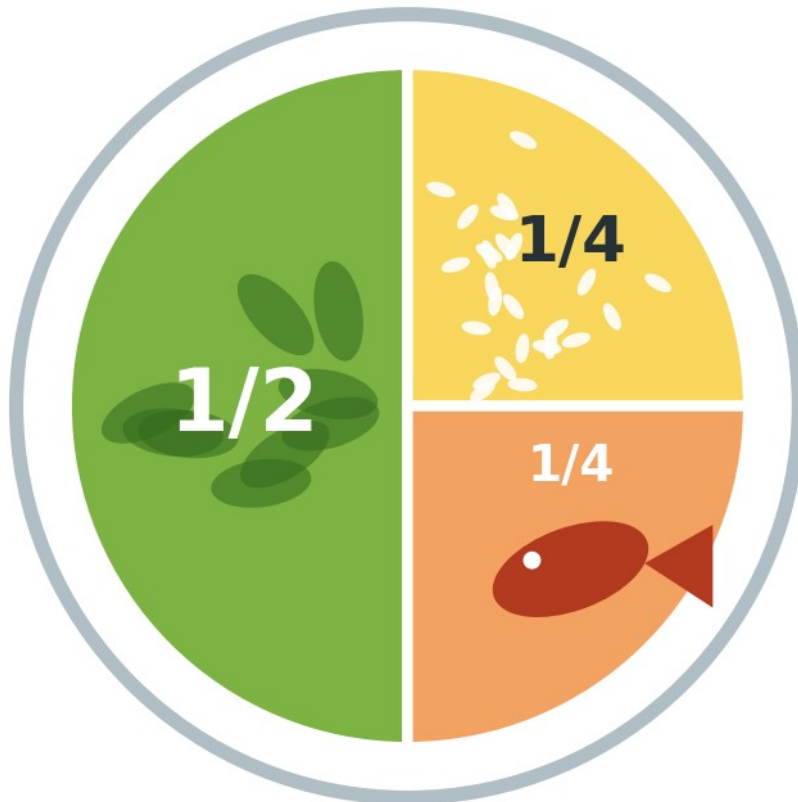


- සුළු බර අඩු කිරීමක්වත් උපකාරී වේ.

- சிறிதளவு எடை குறைப்பும் உதவும்.



- தட்டு முறையைப் பயன்படுத்துங்கள் (D-05): பாதி காய்கறி, கால் பங்கு சோறு, கால் பங்கு புரதம்.
- சோற்றைக் கோப்பையால் அளந்து எடுங்கள். இரண்டாம் முறை போட்டுக்கொள்ள வேண்டாம். சிவப்பரிசியையும் பருப்பு வகைகளையும் தேர்ந்தெடுங்கள்.
- தவிர்க்கவும்: சீனி போட்ட தேநீர், போத்தல் குளிர்பானம், பழச்சாறு, இனிப்புகள், பிஸ்கட், கேக், கவுன், கொகிஸ், பொரித்த உணவுகள்.
- குறைந்த எண்ணெய், தேங்காயில் சமையுங்கள். வேகவைக்கவும், ஆவியில் வேகவைக்கவும் அல்லது பேக் செய்யவும்.
- மெதுவாகச் சாப்பிடுங்கள். வயிறு நிறைந்ததும் நிறுத்துங்கள்.
- சிற்றுண்டி: அவித்த காராமணி அல்லது பாசிப்பயறு, சிறிய பழம் (கொய்யா, பப்பாளி).
- தண்ணீர்: 8 குவளை.
- உடல் மெலிய மாத்திரைகள், தேநீர், மூலிகைப் பொருட்கள் வேண்டாம். கர்ப்பத்திலும் தாய்ப்பாலூட்டும்போதும் ஒருபோதும் வேண்டாம்.

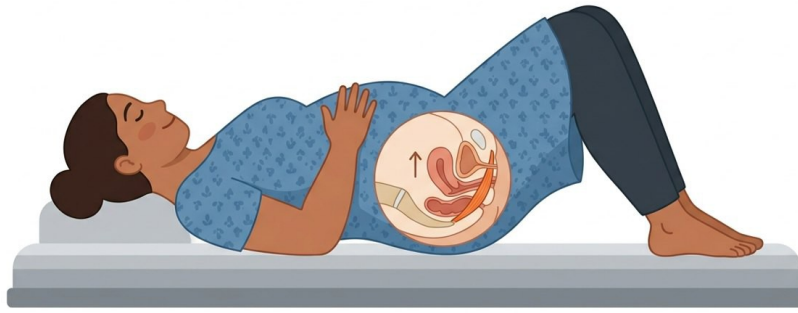


கிளாஸ்டிரோபிசிஸ் (கிளாஸ்டிரோபிசிஸ்)

சுறுசுறுப்பாக இருத்தல் (எல்லோரும்)

- லொஸ்ட் டிஸ்டென்ஸ் 30 க் அரவணு கரந்த. வெலவன் அலிஃரீ வலாக் லோட வெ. மீதிக் 10 கிக் பவன் கந்த.
- வலாஸா கரந்த அகரகூர லலவ ககா கல லகிகி வி ஸ்லக.
- கலவன் லோட டே: பீதீதீ, லரல லோத, ஸ்லீதீ பகூலீ வலாஸா.
- கலரீதீ: ரூவீர வலதல, கரல காதீதீ வி, கரகூலீலீ, பபூலீ வெதலா, கலி லகிகிதீ லோ ட்ரலாஸே வலதல அபூலீ கிகி தல தலகா லலி லாஸதல ட்ரலதீ.
- லலவ டீஸலூலிஸா, அல ரூவீர பீதீதல லோ அபூல அக்தல அரகீதீ டே கல அலதீ.
- பவலும்பாலான நாட்களில் 30 நிமிடம் இலக்கு வலகூங்கல். வேகமாக நடப்பதே சிறந்தது. 10 நிமிடத்தில் தலாடங்கூங்கல்.
- உடற்பயிற்சிபின்போது உங்கலால் பேச முடிய வேண்டும்.
- மேலும் நல்லல: நீச்சல், மலன்மலான யோகா, இலப்பூத்தலத் தலசப் பயிற்சிகல்.
- கர்ப்பிணி: இரத்தப்போக்கு, நீர்க்கசிவு, தலலச்சுற்றல், நலஞ்ச வலி, கருப்பை சுருக்கங்கல் அல்லது குழந்தையின் அலசல குறைதல் இருந்தால் நிறுத்திவிட்டு உங்கல் கிலினிக்கிற்குத் தெரிவிகூங்கல்.
- உங்கலுக்கு நீரிழிவு, உயர் இரத்த அழுத்தம் அல்லது ஆஸ்துமா இருந்தால் எது பாலுலாப்பானது என்று கேளுங்கல்.





O-07 | P, G

**குஜராதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீகமலேஷ்வரேயின் பட்ட (பெர்ரி, பெர்ரி நோவா)
பிரசவத்திற்குப் பின்னும் அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பின்னும் (கர்ப்பிணி,
கர்ப்பமில்லாதவர்)**

- [illegible]



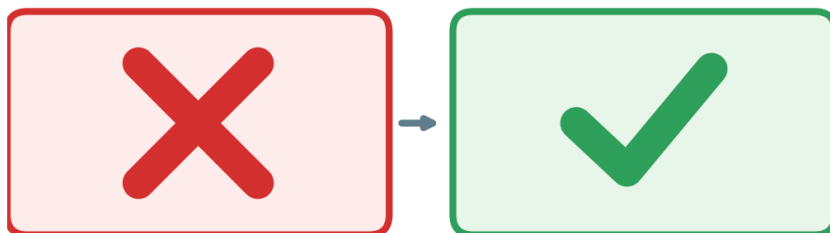
0-08 | All

பேர்ப்பா ஸபா ஸபா (பிடிபுடிபா)

கட்டுக்கதைகளும் உண்மைகளும் (எல்லோரும்)

பேர்ப்பா	ஸபா
"மம டேடினேகும் கும் மிது."	பிடி பிடியேன் பிடி, டேடினேகும் நோபி.
"மம லீ நோகினை மிது."	மிதின டே பிடியேன் லீ கும் கும் து.
"பிதினை கரன லீ பிடிபா பி."	பிடிபா து.
"பிடியா டேடிபா பிபிபிபி."	பிடிபா பிபிபிபி பிபிபிபி பிபி பிபிபிபிபி.

கட்டுக்கதை	உண்மை
"நான் இருவருக்குச் சாப்பிட வேண்டும்."	சற்றுக் கூடுதல் மட்டும்; இரு மடங்கு அல்ல.
"நான் சோறே சாப்பிடக் கூடாது."	அளந்த அளவில் சோறு சாப்பிடலாம்.
"உடல் மெலியும் தேநீர் உதவும்."	பாதுகாப்பானதல்ல.
"உடற்பயிற்சி குழந்தைக்குத் தீங்கு."	தொடர்ந்த மென்மையான உடற்பயிற்சி பாதுகாப்பானதும் பயனுள்ளது.



நிடிநீர்ந தீவ் (஁஁நீவந ஁ய஁ ஁நீவீ஁஁; ஁நீநாவ
஁ீவா ஁ய஁஁஁ ஁யயந ஁நாவ ஁஁஁஁ ஁஁஁஁ ஁஁஁஁)

஁ாதிரி஁ ஁஁஁஁஁஁ (஁஁஁஁஁஁஁஁ ஁ா஁஁஁஁஁஁஁; ஁஁஁஁
஁஁஁஁ ஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁)

S-01 |

நிடிநீர்நய: ஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁

஁ாதிரி: ஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁

஁ீநய	நிரா஁ார஁	஁஁஁ ஁ா஁ார஁஁஁ ஁஁஁ 2	஁஁஁஁஁ ஁ா஁ார஁஁஁ ஁஁஁ 2	஁ா஁ீ ஁ா஁ார஁஁஁ ஁஁஁ 2	நிடிநீர்ந஁஁ ஁஁஁	஁஁஁஁஁஁஁ (஁ீ஁஁)
------	----------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------

- ஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁: நிரா஁ார஁ 95 ஁ ஁஁஁, ஁஁஁ 2 ஁஁ ஁஁஁ 120 ஁ ஁஁஁.

஁ீ஁஁	஁஁஁஁஁ ஁யி஁஁	஁ா஁ீ஁ ஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁ 2 ஁஁஁	஁஁஁ய ஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁ 2 ஁஁஁	஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁ 2 ஁஁஁	஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁	஁஁஁஁஁஁ (஁஁஁஁஁஁)
------	----------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------	--------------------

- ஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁: ஁஁஁஁஁ ஁யி஁஁ 95 ஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁, 2 ஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁ 120 ஁஁஁஁஁஁஁஁.

Date	Fast	B +2h	L +2h	D +2h	Bed	Insulin
12/10	92	118	112	116	104	6 + 10
13/10	90	110	108	114	98	6 + 10
14/10						

S-02 |

நிடிநீர்நய: ஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁

஁ாதிரி: ஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁

஁ீநய	஁஁஁ 1 வந	஁஁஁ 2 வந	஁஁஁ 1 வந	஁஁஁ 2 வந	஁஁஁ ஁஁஁஁஁
------	----------	----------	----------	----------	-----------

- 140/90 ஹை ரீடு வுடீ: ஃயஸனயடு கனா கரந்ந. 160/110 ஹை ரீடு வுடீ, ஹை அநகூர் அஃலவீடு: டீநீடு ரேஃலடு.

தேதி	காலை 1வது	காலை 2வது	மாலை 1வது	மாலை 2வது	அறிகுறிகள்
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

- 140/90 அல்லது அதற்கு மேல்: கிளினிக்கை அழையுங்கள். 160/110 அல்லது அதற்கு மேல், அல்லது ஆபத்து அறிகுறிகள்: உடனே மருத்துவமனைக்கு.

Date	AM 1	AM 2	PM 1	PM 2	Symptoms
12/10	128/82	126/80	130/84	128/82	none
13/10	122/78	120/78	124/80	122/80	none
14/10					

S-03 |

நிடிர்நய: ஓநீஹீரூய ஃல அடூடு ஃரூஃஃடு

மாதிரி: இன்ஹேலரும் ஆஸ்துமாத் திட்டமும்

- கைல: டூடீ ஃல ஃலஃ Seroflo ____ ஃரீ.
- கஃ: Asthalin ____ ஃரீ; அடி ஃயஸனயடு.
- ரகூ: Asthalin ஃகிநீ ஃக ஃரீ; டீநீடு ரேஃலடு.
- ஓநீஹீரூய ஃரூரஃல கல டீநய ____ அலஃநீ ஃந டீநய ____.

- ஃசுஃ: காலை, மாலை Seroflo ____ ஃஃஃ.
- மஞ்சள்: Asthalin ____ ஃஃஃ; இன்றே கிளினிக்கிற்கு.
- சிவஃபு: Asthalin ஓவ்வொரு ஃஃஃஃஃஃ; உடனே மருத்துவமனைக்கு.
- இன்ஹேலர் தொடங்கிய தேதி ____ முடியும் தேதி ____.

Seroflo 2 puffs AM PM

Asthalin 2 puffs + clinic today

Asthalin 1 by 1 HOSPITAL now

start 01/10 finish 20/11

S-04 |

நிதர்சனம்: ஓன்ஃபுரின் பிப்ப

மாதிரி: இன்சலின் பக்கம்

	பேர் (புரீசு)	புரீசு (புரீசு)
புரீசு	_____	_____
புரீசு	_____	_____
புரீசு	_____	_____
புரீசு (புரீசு) புரீசு	_____	_____

- புரீசு புரீசு புரீசு புரீசு _____.

	புரீசு (Soluble, தெளிவான)	புரீசு (புரீசு)
புரீசு	_____	_____
புரீசு	_____	_____
புரீசு	_____	_____
புரீசு (புரீசு) புரீசு	_____	_____

- புரீசு புரீசு புரீசு புரீசு _____.

	Soluble (clear)	Isophane (cloudy)
Morning	6 units	10 units
Lunch	6 units	
Evening	6 units	
Bed		10 units

மாதிரி: தைராய்டு, எடைப் பக்கம்

දිනය	TSH	තයි‍රොක්සීන් මාත්‍රාව	ගෙර්ණි සති ගණන	බර (kg)
------	-----	--------------------------	-------------------	---------

தேதி	TSH	தேராக்சின் அளவு	கர்ப்ப வாரங்கள்	எடை (kg)
------	-----	-----------------	-----------------	----------

Date	TSH	Thyroxine dose	Weeks	Weight (kg)
12/10	2.1	100 mcg	14	61.5
09/11	1.9	100 mcg	18	62.8

Women's Health – Patient Education Book

සෑම සායන පැමිණීමකටම මෙම පොත සහ ඔබේ සායන
පොත ගෙන එන්න.

ඉව්වොරු කිහිනික වරුකෙකුටම ඉන්තප් පුත්තකත්තෙයුම උඟ්කු
කිහිනික පුත්තකත්තෙයුම කොණ්ඩුවාරුඟ්කු.

ගෙර්නි, ප්‍රසූතියෙන් පසු සහ නාරිවේද සායන කාන්තාවන් සඳහා ඉගැන්වීමේ පොත
කර්පිනික, පිරිසවත්තිරුප් පින් මර්ණුම මකප්පේරු අල්ලාත මකුගිර් ඊතාය් කිහිනික
පෙණ්කරුකුකාන කර්පිත්තල් පුත්තකම



ඔබේ දුරකථනයෙන් කියවන්න

උඟ්කු තොළිලපෙසියිල් පඬුඟ්කු

Scan to read this book on your phone

archuthan97.github.io/womens-health-book

Prepared by

Dr. Archuthan Nithiyananthan (RHO)

Translated and Proofread by

Dr. Yasodara Amarasinghe (RHO)

Dr. Kasunika Perera (RHO)

Dr. Madara Malsirini (RHO)